



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROGRAM KERJA
KOMITE KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA (K3RS)
DAN MANAJEMEN FASILITAS DAN
KESELAMATAN (MFK)
TAHUN 2026**

**PROGRAM KERJA KOMITE KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
(KOMITE K3) DAN MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK)
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG TAHUN 2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Umum / Latar Belakang

Rumah Sakit mempunyai karakteristik khusus antara lain banyak menyerap tenaga kerja, padat modal, padat teknologi, bidang pekerjaan dengan tingkat keterlibatan manusia yang tinggi dan terbukanya akses bagi bukan pekerja Rumah sakit (pasien, pengantar dan pengunjung) serta kegiatan yang terus menerus setiap hari. Rumah Sakit merupakan tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung maupun lingkungan rumah sakit. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit perlu diselenggarakan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit agar terciptanya kondisi rumah sakit yang sehat, aman, selamat dan nyaman.

Terkait perizinan di RS pada tahun 2025, terdapat perizinan SIPA dan Pertek belum diselesaikan sebelum masa berlaku izin habis, masa berlaku pertek 30 April 2024 dan masa berlaku SIPA masa berlaku 10 Mei 2025. Selain itu terkait manajemen risiko, *risk register* tahun 2025 belum dilakukan *follow up* tindak lanjut dari risk register yang sudah dibuat. Terkait supervisi sarana dan prasarana belum didokumentasikan dengan baik. Untuk kesehatan kerja, terkait MCU staf diikuti hanya 66.74%, sudah di FU ke SDM tapi tidak ada tindak lanjut dari staf, olahraga bagi karyawan juga vakum yaitu futsal, badminton dan hipnoterapi yang belum berjalan dikarenakan keikutsertaan staf masih rendah, estimasi 10 orang yang mengikuti setiap pertemuan. Untuk pemberian vitamin, makanan tambahan pada staf radiologi dan pemberian vaksin hepatitis pada staf juga belum berjalan. Terkait keselamatan kerja, berdasarkan data kecelakaan kerja di Januari – Oktober 2025, didapatkan bahwa data kecelakaan akibat kerja terbanyak ada pada Kecelakaan Lalu Lintas yaitu 11 insiden kecelakaan lalu lintas.

Terkait keamanan, pemberian badge identitas dan jam besuk pasien kepada pengunjung belum maksimal dilakukan dikarenakan jumlah security terbatas dengan shift sebesar 3-4 orang dan akses pintu dipagi hari terbuka di semua akses RS (4 pintu terbuka). Terkait proteksi kebakaran, pembuatan sistem pemisahan dan kompartemenisasi pengendalian api dan asap dengan pembuatan pintu tahan api pada tangga darurat belum dilakukan.

Terkait sistem utilitas, pembuatan daftar inventaris sistem utilitas dan peta pendistribusian yang update belum dilakukan. Selain itu, belum ada tangki luar untuk tempat BBM pada genset 500 KVA dan belum ada diagram wiring pada listrik. Selain itu, adanya generator set (genset) yang belum dilakukan instalasi kelistrikan juga menjadi ancaman besar ketika genset yang lama mengalami kendala sewaktu terjadi kegagalan listrik.

Untuk pengujian air bersih belum dilakukan sesuai titik yang disesuaikan dengan Permenkes No 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan dimana frekuensi air minum untuk pemeriksaan fisik dan mikrobiologi dilakukan minimal 1 bulan sekali dan 6 bulan sekali untuk pemeriksaan kimia.

Sedangkan berdasarkan Permenkes 7 Tahun 2019 tentang Kesling, pengambilan air untuk kegunaan higiene dan sanitasi dengan pemeriksaan parameter mikrobiologi diutamakan dilakukan pada lokasi yang memiliki risiko tinggi terjadinya pencemaran/kontaminasi, meliputi: tangki utama, kamar operasi, ruang intensif, UGD, ruang perinatology, kamar bersalin, ruang luka bakar, dapur gizi, sterilisasi/CSSD, laundry,

laboratorium, kantin/restoran, poliklinik gigi. Pengambilan air untuk kegunaan higiene dan sanitasi dengan pemeriksaan parameter fisika-kimia dilakukan pada tangki utama, laundry, laboratorium, farmasi, gizi, air boiler. Air untuk kegunaan khusus dan tanggap darurat rumah sakit seperti air panas, *cooling tower*, pencucian mata (*eye washer*) dan pencucian badan (*body washer*) harus dilakukan pemeriksaan bakteri *Legionella spp* setiap 1 (satu) kali setahun, dan dilakukan pemeliharaan pembersihan fasilitas setiap minggu. Terkait dengan renovasi, konstruksi dan demolisi ketika pembangunan tidak melibatkan Komite K3 dalam pelaksanaan rapat pra konstruksi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, melatarbelakangi suatu program terkait Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) dimana merupakan bagian dari Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) dalam rangka menciptakan mutu pelayanan yang paripurna beserta perlindungan baik keselamatan dan kesehatan bagi pasien, petugas, keluarga pasien, pengunjung dan orang-orang yang berada dilingkungan Rumah Sakit dengan sub program didalamnya meliputi kepemimpinan dan perencanaan, keselamatan, keamanan, pengelolaan B3 dan limbahnya, proteksi kebakaran, peralatan medis, sistem utilitas, penanganan kedaruratan dan bencana, konstruksi dan renovasi dan pelatihan.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan bahan Nuklir;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
23. Peraturan Pemerintah RI nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang

-
- Perumasakitan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 26. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
 27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumasakitan;
 28. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 04 Tahun 1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;
 29. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 02 Tahun 1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatik;
 30. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02 Tahun 1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir;
 31. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 472 Tahun 1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan;
 32. Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan;
 33. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 363 Tahun 1998 tentang pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Pada Sarana Pelayanan Kesehatan;
 34. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
 35. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 36. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun;
 37. Permenakertrans Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja.
 38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
 39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 41. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 42. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
 43. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
 44. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri;
 45. Peraturan Menteri Tenaga Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/II/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
 46. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 Tahun 2011 tentang Penerapan Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
 47. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1171 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit;
 48. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/MENKES/PER/VII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
 49. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2306 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Prasarana Instalasi Elektrikal Rumah Sakit
 50. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan Atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 51. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
 52. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 53. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;

-
54. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 55. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
 56. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penggunaan Gas Medik dan Vakum Medik Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 57. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
 58. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit;
 59. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik;
 60. Peraturan Menteri Kesehatan No 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
 61. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
 62. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 63. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 64. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 65. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 66. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
 67. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan Atau Kegiatan Usaha Lainnya;
 68. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: KEP-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 69. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit.
 70. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;
 71. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;
 72. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.Kep 187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja;
 73. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 205 Tahun 1999 tentang Prosedur Permintaan Bantuan dan Pengiriman Bantuan;
 74. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 75. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1439 Tahun 2022 tentang Gas Medik;
 76. Keputusan Menteri Kesehatan RI 1075/MENKES/SK/VII/ 2003 tentang Pedoman Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Kerja;
 77. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
 78. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1653/MENKES/SK/XII/2005 tentang Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan;
 79. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 066/MENKES/ SK/11/2006 tentang Pedoman Penanggulangan Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana;
 80. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 145/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana di Bidang Kesehatan;
 81. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 432/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Rumah Sakit;

-
82. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1105/MENKES/ SK/IX/2007 tentang Pedoman Penanganan Medis Korban Masal Akibat Bencana Kimia;
 83. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1087/MENKES/ SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatandan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit;
 84. Keputusan Menteri RI Nomor 059/MENKES/SK/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Penanggulangan Bencana;
 85. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01/07/MENKES/ 1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
 86. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43961/ 2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit;
 87. Keputusan Direktur Jendral HK -025-02-D-47104-2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
 88. Pedoman Penatalaksanaan Pengelolaan Limbah Padat dan Limbah Cair di Rumah Sakit;
 89. Pedoman Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Tahun 2001;
 90. Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kelas C, Departemen Kesehatan RI Tahun 2007;
 91. Pedoman Teknis Prasarana Rumah Sakit, Sistem Proteksi Kebakaran Aktif, Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Direktorat Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan 2012;
 92. Pedoman Penerbitan Rekomendasi Pengangkutan LimbahBahan Berbahaya dan Beracun (B3). Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2015;
 93. Pedoman Pengelolaan Peralatan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2015;
 94. *Occupational Health and Safety Management Sitems* (OHSAS 18001:2007) tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 95. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 96. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 97. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
 98. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di Fasyankes;
 99. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Fasyankes;
 100. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
 101. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
 102. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
 103. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;
 104. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 263/DPM/I-KEP/DIR/I/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Tersedianya program kerja dalam Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) dan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK).

2. Tujuan Umum

Terlaksananya program Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) dan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK).

3. Tujuan Khusus

- a. Terlaksananya program terkait kepemimpinan dan perencanaan;
- b. Terlaksananya program terkait keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. Terlaksananya program terkait keamanan;
- d. Terlaksananya program terkait pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbahnya;
- e. Terlaksananya program terkait proteksi kebakaran;
- f. Terlaksananya program terkait peralatan medis;
- g. Terlaksananya program terkait sistem utilitas;
- h. Terlaksananya program terkait penanganan kedaruratan dan bencana;
- i. Terlaksananya program terkait konstruksi dan renovasi;
- j. Terlaksananya program terkait pelatihan MFK

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat

2.2 Misi

1. Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat;
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien;
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

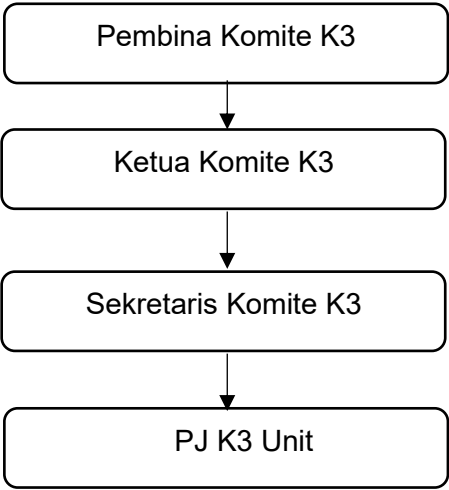
2.3 Motto

Sahabat Menuju Sehat

2.4 7 Nilai Budi Utama

1. Jujur
2. Tanggungjawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 SOTK Unit



2.6 Permasalahan Kinerja Tahun 2025

No	Pokok Permasalahan	Rincian Permasalahan
1.	Perizinan / Legalitas RS	Perizinan SIPA dan Pertek belum diselesaikan sebelum masa berlaku izin habis, masa berlaku pertek 30 April 2024 dan masa berlaku SIPA masa berlaku 10 Mei 2025.
2.	Manajemen Risiko	Manajemen risiko belum dilakukan follow up tindak lanjut dari risk register yang sudah dibuat.
3.	Supervisi Sarpras	Supervisi sarana dan prasarana belum didokumentasikan dengan baik
4.	MCU Staf	MCU staf diikuti hanya 66.74%, sudah di FU ke SDM tapi tidak ada tindak lanjut dari staf
5.	Kesehatan Kerja	Futsal, Badminton dan hipnoterapi belum berjalan dengan adekuat dikarenakan range keikutsertaan staf rendah sekitar 10 orang dengan per pertemuan untuk badminton dan jadwal yang berseberangan antar unit.
6.	Kesehatan Kerja	Pemberian vitamin pada staf belum berjalan
		Pemberian makanan tambahan staf radiologi belum berjalan adekuat
		Pemberian vaksin hepatitis belum dilakukan
7.	Keselamatan Kerja	Pada Bulan Januari – Oktober 2025, didapatkan bahwa data kecelakaan akibat kerja terbanyak ada pada Kecelakaan Lalu Lintas yaitu 11 insiden kecelakaan lalu lintas.
8.	Keamanan	Pemberian badge identitas dan jam besuk pasien kepada pengunjung belum maksimal dilakukan dikarenakan jumlah security terbatas dengan pe shift sebesar 3-4 orang dan akses pintu dipagi hari terbuka di semua akses RS (4 pintu terbuka).
9.	Proteksi Kebakaran	Pembuatan sistem pemisahan dan kompartemenisasi pengendalian api dan asap dengan pembuatan pintu tahan api pada tangga darurat.

No	Pokok Permasalahan	Rincian Permasalahan
10.	Sistem Utilitas	Pembuatan daftar inventaris sistem utilitas dan peta pendistribusian yang update belum dilakukan.
11.	Sistem Utilitas	Penambahan tangki bahan bakar genset belum ada
12.	Sistem Utilitas	Pembuatan diagram wiring listrik belum dilakukan
13.	Pengujian Air	Pengujian air bersih belum disesuaikan dengan peraturan yang ada.
15.	Konstruksi dan Renovasi	Renovasi, demolisi dan konstruksi yang tidak diketahui dan melibatkan Komite K3 .

BAB III
KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

3.1 Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1.	Kepemimpinan dan Perencanaan	Pengarsipan dan administrasi terkait regulasi di Rumah Sakit
		Pengarsipan dan administrasi terkait perizinan di Rumah Sakit
2.	Manajemen Risiko	Manajemen risiko fasilitas, keselamatan dan keamana dan berkaitan dengan MFK
3.	Keselamatan	Penyediaan handrail di kamar mandi pasien
		Penyediaan side rail di bed pasien berfungsi dengan baik
		Penyediaan APD di rumah sakit
		Mapping area berisiko keselamatan
		Melakukan supervisi terkait sarana dan prasarana (ronde fasilitas)
4.	Kesehatan Staf	<i>Medical Check Up (MCU)</i> secara berkala pada seluruh karyawan
		<i>Rectal Swab</i> pada penjamah makanan
		Senam Kesehatan Jumat Berkah
		Futsal bagi Karyawan Laki-Laki
		Badminton bagi Staf
		Hipnoterapi pada Staf
		Pemberian vitamin bagi staf
		Pemberian makanan tambahan bagi seluruh staf setiap Hari Jumat
		Pemberian makanan tambahan bagi staf Radiologi
		Pemberian fasilitas BPJS TK bagi staf
		Pemberian vaksin hepatitis bagi staf yang berada di area risiko tinggi misalnya IKO, ICU, IGD, Laboratorium, Maternitas, Perinatologi, IRJA, IRNA, Petugas B3, CSSD dan Laundry dan Petugas <i>Cleaning Service (CS)</i> .
5.	Keamanan	Pemberian identitas (<i>badge</i> nama sementara atau tetap) pada pasien, staf, pekerja kontrak, tenant (penyewa lahan), keluarga (penunggu pasien) atau pengunjung (pengunjung diluar jam besuk dan tamu RS
		Pemeriksaan dan pemantauan fasilitas dan lingkungan melalui CCTV selama 24 jam oleh petugas security dalam menghindari risiko keamanan

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
		Pemeriksaan dan pemantauan fasilitas dan lingkungan melalui patroli keamanan oleh petugas security.
		Pengelolaan risiko kekerasan, kejahatan dan acaman dilingkungan Rumah Sakit
6.	Pengelolaan B3 dan Limbahnya	Pembuatan Panduan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbahnya secara <i>update</i> Inventarisasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbahnya yang meliputi jenis, jumlah, simbol dan lokasi Penanganan, penyimpanan dan penggunaan B3 dan limbahnya Pelatihan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan prosedur bila terjadi tumpahan paparan/pajanan (<i>spill kit</i> dan <i>eye washer</i>) Pelatihan yang dilakukan oleh staf yang menangani Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Pemberian label/rambu-rambu yang tepat pada B3 dan limbahnya Pelaporan dan investigasi dari tumpahan, eksposur (terpapar) dan insiden lainnya, dimana termasuk pemenuhan spill kit Pengarsipan dokumentasi, termasuk izin, lisensi, atau persyaratan peraturan lainnya Melampirkan Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) atau <i>Material Safety Data Sheet (MSDS)</i> ketika pengadaan/pembelian B3 dan pemasok (supplier). Melakukan penyimpanan limbah di TPS B3 sesuai aturan yang berlaku Pengukuran pH dan debit air limbah Melakukan pengolahan limbah B3 dengan pihak ketiga sesuai Mou yang berlaku
7.	Proteksi Kebakaran	Penyimpanan dan penanganan bahan bahan mudah terbakar secara aman termasuk gas-gas medis yang mudah terbakar dengan pemasangan rantai dan pengaman lainnya Pengendalian potensi bahaya dan risiko kebakaran yang terkait dengan

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
		konstruksi apapun di atau yang berdekatan dengan bangunan yang ditempati pasien
		Penyediaan rambu dan jalan keluar (evakuasi) yang aman
		Penyediaan dan pemeliharaan sistem peringatan dini secara pasif meliputi detector asap, detector panas, alarm kebakaran dan lain-lain
		Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pemadam api aktif meliputi APAR, hydrant, sistem sprinkler dan lain-lain
		Pembuatan sistem pemisahan (pengisolasian) dan kompartemenisasi pengendalian api dan asap
		Inventarisasi, pemeriksaan berkala, uji coba dan pemeliharaan berkala sistem pemadam kebakaran aktif dan pasif di RS
		Identifikasi area berisiko kebakaran
		Simulasi kebakaran minimal setahun sekali
		Monitoring pelaksanaan monitoring Kawasan Tanpa Merokok (KTR).
8.	Pengelolaan Peratalan Medis	Identifikasi penilaian kebutuhan peralatan medis beserta uji fungsi
		Inventarisasi peralatan medis baik yang KSO ataupun yang Non-KSO
		Melakukan uji fungsi pada peralatan medis baru
		Pemeriksaan peralatan medis
		Pengujian peralatan medis
		Pemeliharaan preventif dan kalibrasi peralatan medis
		Pemantauan, pemberitahuan kerusakan (malfungsi) dan penarikan (<i>recall</i>) peralatan medis yang membahayakan pasien
		Memastikan ketersediaan air dan listrik 24 jam setiap hari dan dalam waktu 7 hari dalam seminggu
		Pembuatan daftar inventaris sistem utilitas dan peta distribusinya
		Melakukan pemeriksaaan, pemeliharaan, serta perbaikan semua komponen utilitas yang ada di daftar inventaris dan komponen kritisnya dan sumber alternatif
		Membuat jadwal pemeriksaan, uji fungsi dan pemeliharaan semua

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
		sistem utilitas berdasar atas kriteria seperti rekomendasi dari pabrik, tingkat risiko, dan pengalaman rumah sakit
		Pelabelan tuas-tuas kontrol pada sistem utilitas
		Mengidentifikasi peralatan, sistem, serta area yang memiliki risiko paling tinggi terhadap pasien dan staf
		Pengujian sumber cadangan atau alternatif air bersih dan listrik minimal 6 bulan sekali dan mendokumentasikan
		Monitoring dan pemeriksaan mutu air bersih
		Monitoring dan pemeriksaan mutu air limbah
		Monitoring pemeriksaan mutu air yang digunakan untuk dialisis ginjal setiap bulan untuk menilai pertumbuhan bakteridan endotoksin
		Pembuatan denah update terkait seluruh infrastruktur di Rumah Sakit
		Penambahan tangki bahan bakar genset
		Pembuatan digram wiring listrik.
		Instalasi genset baru 1000 KVA
9.	Penanggulangan Bencana	Pembuatan regulasi penanggulangan bencana
		Pembuatan <i>Hazard Vulnerability Analylis (HVA)</i>
		Pembuatan tim penanggulangan keadaan darurat
		Simulasi penanggulangan keadaan darurat
		Penyediaan area dekontaminasi pada Instalasi Gawat Darurat (IGD)
		Melaksanakan PCRA ketika proses renovasi, kontruksi dan demolisi
10.	Pelatihan MFK	Pelatihan MFK terkait keselamatan
		Pelatihan MFK terkait keamanan
		Pelatihan MFK terkait pengelolaan B3 dan limbahnya
		Pelatihan MFK terkait proteksi kebakaran
		Pelatihan MFK terkait peralatan medis
		Pelatihan MFK terkait sistem utilitas
		Pelatihan MFK terkait penanganan bencana
		Pelatihan MFK kepada vendor, pekerja kontrak, relawan, pelajar,

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
		peserta didik, peserta pelatihan dan lainnya (jika ada).
		Pelatihan eksternal terkait Ahli K3 Listrik
		Pelatihan eksternal terkait K3 Rumah Sakit
		Pelatihan eksternal terkait Safety Driving dan Riding

3.2 Sasaran

No.	Rincian Kegiatan	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Jenis	Target/Standart	Indikator Keberhasilan	Keterangan
1.	Pengarsipan dan administrasi terkait regulasi di Rumah Sakit	Agar seluruh regulasi di RS terarsip dengan baik	Semua Regulasi di RS – Legal-Sekretaris RS	Regulasi RS	100 %	Administrasi dan regulasi terarsip	Update regulasi terbaru sesuai peraturan pemerintah
2.	Pengarsipan dan administrasi terkait perizinan di Rumah Sakit	Agar perizinan terarsip dengan baik	Semua perizinan – Legal – Sekretaris RS	Perizinan RS	100 %	Administrasi dan perizinan terarsip dengan baik	Berkoordinasi dengan Legal PT dan Sekreraris RS dengan mengumpulkan : 1. IMB 2. Izin Operasional 3. Izin Pertek 4. Izin Genset 5. Izin Listrik 6. Izin Rintek 7. Izin lift 8. Izin Pnyalur Petir 9. Izin Lingkungan 10. Sertifikat Laik Operasi 11. MoU dengan Transporter dan Pengolah B3 12. Izin BAPETEN (Izin ESWL, Izin Mobile X-Ray, Izin CT-Scan) 13. Dan semua izin yang berkaitan dengan legalitas Rumah Sakit
3.	Manajemen risiko fasilitas dan keselamatan	Untuk mengidentifika si, menilai dan	Semua karyawan	Risk Register 2026	Terdapat <i>risk register</i>	Terdapatnya <i>risk register</i> dan upaya pengendalian risiko	Risk Register terkait fasilitas dan keselamatan

No.	Rincian Kegiatan	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Jenis	Target/Standart	Indikator Keberhasilan	Keterangan
		melakukan pengendalian risiko fasilitas dan keselamatan			tahun 2026		
4.	Penyediaan handrail di kamar mandi pasien	Penyediaan sarana keselamatan untuk pasien	Semua kamar mandi pasien	Supervisi Sarana	100 %	Tersedianya handrail di semua kamar mandi pasien	Kamar mandi yang belum terdapat handrail sebanyak 33 pcs
5.	Penyediaan <i>side rail</i> di bed pasien berfungsi dengan baik	Penyediaan sarana keselamatan untuk pasien	Semua bed pasien	Supervisi	100 %	Side rail berfungsi baik	Perbaikan siderail secara berkala jika mengalami kerusakan
6.	Penyediaan APD di rumah sakit	Melindungi karyawan rumah sakit	Semua karyawan	Supervisi	100 %	Tersedia APD di unit	Berkoordinasi dengan PPI terkait
7.	Mapping area berisiko keselamatan	Agar tersedia mapping area berisiko keselamatan	Semua area Rumah Sakit	Mapping Area	Tersedia denah area berisiko	Terdapat denah area berisiko	
8.	Melakukan supervisi terkait sarana dan prasarana	Untuk memelihara sarana dan prasarana yang ada	Semua sarana dan prasarana	Supervisi	100 %	Terlaksana supervisi sarana dan prasarana	Dengan melakukan keliling untuk pengecekan seluruh sarana di Rumah Sakit secara berkala
9.	<i>Medical Check Up (MCU)</i> secara Berkala pada Seluruh Karyawan	Untuk mengetahui derajat kesehatan staf	Seluruh staf	Pemeriksaan foto rontgen dan lab darah	100 %	Terlaksana <i>Medical Check Up (MCU)</i> pada seluruh staf	Pemeriksaan dokter umum untuk semua staf

No.	Rincian Kegiatan	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Jenis	Target/Standart	Indikator Keberhasilan	Keterangan
10.	Rectal Swab pada penjamah makanan	Untuk mengetahui derajat kesehatan penjamah makanan	Staf Penjamah Makanan	Laporan rectal swab	100 %	Rectal Swab kepada seluruh penjamah makanan setiap 6 bulan	Penjamah makan sebanyak 10 orang setiap 6 bulan sekali
11.	Senam Kesehatan Jumat Berkah	Untuk memelihara kesehatan staf	Seluruh Staf dan Lansia di area sekitar RS	Umandok senam	100 %	Dilaksanakan senam kesehatan setiap Jumat	Setiap Hari Jumat
12.	Futsal bagi Karyawan Laki-Laki	Untuk memelihara kesehatan staf	Staf laki-laki	Umandok senam	100 %	Terlaksana futsal karyawan	
13.	Badminton bagi Staf	Untuk memelihara kesehatan staf	Seluruh Staf	Umandok badminton	100 %	Terlaksana badminton	
14.	Hipnoterapi pada Staf	Untuk memelihara kesehatan staf	Seluruh Staf yang membutuhkan	Umandok hipnoterapi	100 %	Terlaksana hipnoterapi 6 bulan sekali	6 bulan sekali
15.	Pemberian vitamin bagi staf	Untuk memelihara kesehatan staf	Seluruh Staf	Umandok pemberian vitamin	100 %	Terlaksana pemberian vitamin	
16.	Pemberian makanan tambahan bagi seluruh staf setiap Hari Jumat	Untuk memelihara kesehatan staf	Seluruh Staf	Dokumenta si	100 %	Terlaksana pemberian makanan tambahan setiap Jumat	
17.	Pemberian makanan tambahan bagi staf Radiologi	Untuk memelihara kesehatan staf	Seluruh Staf Radiologi	Dokumenta si	100 %	Terlaksana pemberian makanan tambahan bagi petugas Radiologi	

No.	Rincian Kegiatan	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Jenis	Target/Standart	Indikator Keberhasilan	Keterangan
18.	Pemberian fasilitas BPJS TK bagi staf	Untuk mengcover jika terjadi KAK dan PAK pada karyawan	Seluruh Staf , non orientasi	Pelaporan SDM	100 %	Semua karyawan mempunyai BPJS Ketenagakerjaan (TK)	
19.	Pemberian vaksin hepatitis bagi staf yang berada di area risiko tinggi misalnya IKO, ICU, IGD, Laboratorium, Maternitas, Perinatologi, IRJA, IRNA, Petugas B3, CSSD dan Laundry dan Petugas <i>Cleaning Service</i> (CS).	Untuk mencegah penyakit hepatitis pada staf terkait	Staf IKO, ICU, IGD, Laboratorium, Maternitas, Perinatologi, IRJA, IRNA, Petugas B3, CSSD dan Laundry dan Petugas <i>Cleaning Service</i> (CS).	Hasil MCU	100 %	Staf dengan area berisiko tinggi IKO, ICU, IGD, Laboratorium, Maternitas, Perinatologi, IRJA, IRNA, Petugas B3, CSSD dan Laundry dan Petugas <i>Cleaning Service</i> (CS) divaksin hepatitis	
20.	Pemberian identitas (<i>badge</i> nama sementara atau tetap) pada pasien, staf, pekerja kontrak, tenant (penyewa lahan), keluarga (penunggu pasien) atau pengunjung (pengunjung diluar jam besuk dan tamu RS	Untuk mengetahui identitas staf, penjaga pasien atau vendor dan menjaga keamanan RS	Pasien, staf, pekerja kontrak, tenant (penyewa lahan), keluarga (penunggu pasien) atau pengunjung (pengunjung diluar jam besuk dan tamu RS	Supervisi Security	100 %	Semua yang berada di Rumah sakit memakai tanda pengenal	

No.	Rincian Kegiatan	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Jenis	Target/Standart	Indikator Keberhasilan	Keterangan
21.	Pemeriksaan dan pemantauan fasilitas dan lingkungan melalui CCTV selama 24 jam oleh petugas security dalam menghindari risiko keamanan	Untuk memantau semua area Rumah Sakit	Semua Area Rumah Sakit kecuali kamar pasien dan area privasi pasien	Supervisi Security	100 %	Dilakukan pemantauan CCTV	
22.	Pemeriksaan dan pemantauan fasilitas dan lingkungan melalui patroli keamanan oleh petugas security.	Untuk menjaga keamanan RS	Semua area RS – Security	Supervisi	100 %	Dilakukan patroli oleh security dan keamanan RS 1007 terjaga	
23.	Pengelolaan risiko kekerasan, kejahatan dan acaman dilingkungan Rumah Sakit	Untuk mengetahui pengelolaan risiko kekerasan di RS	Semua Staf	Sosialisasi	100 %	Risiko kekerasan dikelola dengan baik	
24.	Pembuatan Panduan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbahnya	Agar terdapat pedoman terkait pengelolaan B3 dan limbahnya	Seluruh B3 dan limbahnya – Seluruh Unit	Pedoman Pengolahan B3	100 %	Tersedianya Panduan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbahnya	
25.	Inventarisasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbahnya yang meliputi jenis, jumlah, simbol dan lokasi	Untuk mengetahui inventarisasi B3 dan	Agar semua B3 dan limbahnya mampu	Inventaris B3	100 %	Tersedia inventarisasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbahnya yang meliputi	

No.	Rincian Kegiatan	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Jenis	Target/Standart	Indikator Keberhasilan	Keterangan
		limbahnya secara update	terinventarisasi dengan baik			jenis, jumlah, simbol dan lokasi	
26.	Penanganan, penyimpanan dan penggunaan B3 dan limbahnya	Mengetahui cara penanganan, penyimpanan dan penggunaan B3 dan limbahnya	Semua B3 dan limbahnya	Manifest pengambilan limbah	100 %	Penanganan, penyimpanan dan penggunaan B3 dan limbahnya terkelola dengan baik	
27.	Pelatihan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan prosedur bila terjadi tumpahan paparan/pajanan (<i>spill kit</i> dan <i>eye washer</i>)	Mengetahui cara penanganan B3 dan limbahnya	Semua Staf	Sosialisasi	100 %	Telah dilakukan pelatihan APD dan penggunaan spill kit serta alur jika terpajan/terpapar bahan kimia	
28.	Pelatihan yang dilakukan oleh staf yang menangani Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Mengetahui cara menangani B3	Semua Staf	Sosialisasi	100 %	Dilaksanakan pelatihan penanganan B3 dan limbahnya	
29.	Pemberian label/rambu-rambu yang tepat pada B3 dan limbahnya	Mengetahui cara pemberian label/rambu pada B3 dan limbahnya	Semua B3 dan limbahnya	Dokumentasi	100 %	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbahnya terdapat label/rambu-rambu	
30.	Pelaporan dan investigasi dari tumpahan, eksposur (terpapar) dan insiden	Mengetahui cara pelaporan tumpahan B3	Semua staf	Laporan tumpahan	100 %	Tumpahan dan insiden terpapar telah dilaporkan dan diinvestigasi	

No.	Rincian Kegiatan	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Jenis	Target/Standart	Indikator Keberhasilan	Keterangan
	lainnya, dimana termasuk pemenuhan spill kit	dan investigasi tumpahan, paparan atau exposur		dan pajanan			
31.	Pengarsipan dokumentasi, termasuk izin, lisensi, atau persyaratan peraturan lainnya	Melakukan pengarsipan dokumentasi, izin, lisensi dan persyaratan lainnya terkait B3	Semua vendor terkait B3 yang melakukan MoU dengan RS	Dokumentasi dan legalitas vendor	100 %	Dokumentasi, termasuk izin, lisensi, atau persyaratan peraturan lainnya terkait MFK dilakukan pengarsipan	
32.	Melampirkan Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) atau <i>Material Safety Data Sheet (MSDS)</i> ketika pengadaan/pembelian B3 dan pemasok (supplier).	Untuk mengetahui cara penanganan apabila terdapat kecelakaan terkait B3	Semua unit yang melakukan penyimpanan B3	MSDS	100 %	Terdapat Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) atau <i>Material Safety Data Sheet (MSDS)</i> setiap pembelian B3	
33.	Melakukan penyimpanan limbah di TPS B3 sesuai aturan yang berlaku	Agar limbah disimpan di TPS B3 sesuai aturan yang berlaku	Limbah padat B3	Penyimpanan limbah B3	100%	B3 dilakukan penyimpanan sebelum diambil pihak ketiga max 2x24 jam	
34.	Pengukuran pH dan debit air limbah	Untuk mengetahui nilai pH dan	Air limbah	Pengukuran dengan alat pengukur	100 %	pH dan debit air limbah terpantau setiap harinya	

No.	Rincian Kegiatan	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Jenis	Target/Standart	Indikator Keberhasilan	Keterangan
		debit air limbah		pH dan debit			
35.	Melakukan pengolahan limbah B3 dengan pihak ketiga sesuai Mou yang berlaku	Untuk mengelola limbah B3 di RS sesuai aturan yang berlaku	Limbah padat B3	Pengelolaan limbah oleh pihak ketiga	100 %	Terdapat manifest pengambilan limbah B3	
36.	Penyimpanan dan penanganan bahan mudah terbakar secara aman termasuk gas-gas medis yang mudah terbakar dengan pemasangan rantai dan pengaman lainnya	Untuk mencegah terjadi kebakaran dengan penyimpanan bahan mudah terbakar yang adekuat	Gudang Penyimpanan B3 dan Gas Medis	Dokumentasi penyimpanan gas medis	100 %	Penyimpanan dan penanganan bahan mudah terbakar ditangani dengan baik	
37.	Pengendalian potensi bahaya dan risiko kebakaran yang terkait dengan konstruksi apapun di atau yang berdekatan dengan bangunan yang ditempati pasien	Untuk memproteksi bangunan RS dari risiko kebakaran	Jalur keluar menuju titik kumpul	Pembangunan tembok atau mengurasi partisi di RS	100 %	Risiko kebakaran terkait konstruksi atau yang berdekatan dengan bangunan pasien safety	
38.	Penyediaan rambu dan jalan keluar (evakuasi) yang aman	Agar tersedia rambu yang mempermudah	Rambu evakuasi, titik kumpul dan pintu keluar	Dokumentasi rambu evakuasi	100 %	Tersedia rambu evakuasi dan titik kumpul yang aman	

No.	Rincian Kegiatan	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Jenis	Target/Standart	Indikator Keberhasilan	Keterangan
		proses evakuasi	(Rambu untuk Proses evakuasi)				
39.	Penyediaan dan pemeliharaan sistem peringatan dini secara pasif meliputi detector asap, detector panas, alarm kebakaran dan lain-lain	Agar tersedia detector untuk mendeteksi adanya risiko kebakaran	Seluruh bangunan di RS yang berisiko kebakaran	Pemeliharaan alat alat pemadam api pasif	100 %	Tersedia dan terpelihara sistem peringatan dini secara pasif meliputi detector asap, detector panas, alarm kebakaran dan lain-lain	
40.	Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pemadam api aktif meliputi APAR, hydrant, sistem sprinkler dan lain-lain	Agar tersedia sarana untuk mengatasi adanya risiko kebakaran	Seluruh bangunan di RS yang berisiko kebakaran	Penyediaan pemeliharaan pemadam api aktif	100 %	Tersedia dan terpelihara fasilitas pemadam api aktif meliputi APAR, hydrant, sistem sprinkler dan lain-lain	
41.	Pembuatan sistem pemisahan (pengisolasian) dan kompartemenisasi pengendalian api dan asap	Agar tersedia sarana untuk mengisolasi dan kompartemenisasi pengendalian asap	Seluruh bangunan di RS yang berisiko kebakaran	Pembuatan ruangan pengisolasi asarp atau penambahan pintu tahan api dengan ketahanan api minimal 2 jam	100 %	Terdapat sistem pemisahan dan kompartemenisasi pengendalian api dan asap	

No.	Rincian Kegiatan	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Jenis	Target/Standart	Indikator Keberhasilan	Keterangan
42.	Inventarisasi, pemeriksaan berkala, uji coba dan pemeliharaan berkala sistem pemadam kebakaran aktif dan pasif di RS	Agar terdapat inventaris dan pemeriksaan serta pemeliharaan terkait sistem pemadam api aktif dan pasif	Semua sistem penanggulangan kebakaran	Inventarisasi alat alat pemadam kebakaran	100 %	Tersedia inventarisasi pemeriksaan berkala, uji coba dan pemeliharaan berkala sistem pemadam kebakaran aktif dan pasif di RS	
43.	Identifikasi area berisiko kebakaran	Untuk melakukan identifikasi area berisiko dalam rangka pencegahan kebakaran	Semua area berisiko kebakaran	Mapping area berisiko kebakaran	100 %	Area berisiko kebakaran telah diidentifikasi	
44.	Simulasi kebakaran minimal setahun sekali	Untuk mengetahui cara tanggap ketika terjadi keadaan darurat	Semua Staf – K3RS	Umandok simulasi kebakaran	100 %	Terlaksana simulasi kebakaran minimal setahun sekali	
45.	Monitoring pelaksanaan monitoring Kawasan Tanpa Merokok (KTR).	Untuk mengetahui tingkat kepatuhan KTR	Semua Area RS - Security	Form monitoring KTR	100 %	Terlaksana monitoring KTR	
46.	Identifikasi penilaian kebutuhan peralatan medis beserta uji fungsi	Untuk mengidentifikasi kebutuhan	Seluruh peralatan medis -ATEM	Identifikasi kebutuhan peralatan	100 %	Telah dilakukan identifikasi penilaian kebutuhan	

No.	Rincian Kegiatan	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Jenis	Target/Standart	Indikator Keberhasilan	Keterangan
		peralatan medis		medis dan uji fungsi alkes		peralatan medis beserta uji fungsi	
47.	Inventarisasi peralatan medis	Untuk melakukan pendataan terhadap alat medis	Seluruh peralatan medis -ATEM	Inventarisasi alkes	100 %	Peralatan medis telah dilakukan inventarisasi	
48.	Melakukan uji fungsi pada peralatan medis baru	Agar alat medis berfungsi dengan baik selama masa pemakaian dan melakukan pengecekan alat medis baru	ATEM dan user peralatan medis baru	Sosialisasi	100%	Peralatan medis baru telah dilakukan uji fungsi dan terdapat umandok uji fungsi	
49.	Pemeriksaan peralatan medis	Agar alat medis dilakukan pemeriksaan secara berkala	Seluruh peralatan medis -ATEM	Form pemeriksaan alkes	100 %	Peralatan medis telah diperiksa	
50.	Pengujian peralatan medis	Agar alat medis dilakukan pengujian secara berkala	Seluruh peralatan medis -ATEM	Umandok pengujian alkes	100 %	Peralatan medis telah dilakukan pengujian	

No.	Rincian Kegiatan	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Jenis	Target/Standart	Indikator Keberhasilan	Keterangan
51.	Pemeliharaan preventif dan kalibrasi peralatan medis	Agar alat medis dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi secara berkala	Seluruh peralatan medis -ATEM	Sertifikat kalibrasi	100 %	Peralatan medis telah dilakukan upaya pemeliharaan preventif dan kalibrasi	
52.	Pemantauan, pemberitahuan kerusakan (malfungsi) dan penarikan (<i>recall</i>) peralatan medis yang membahayakan pasien	Agar terdapat pemberitahuan terkait alat medis yang recall	Semua alat medis yang recall -ATEM	Laporan recall alkes	100 %	Peralatan medis yang membahayakan pasien telah dilakukan pemantauan dan pemberitahuan	
53.	Memastikan ketersediaan air dan listrik 24 jam setiap hari dan dalam waktu 7 hari dalam seminggu	Agar terdapat air dan listrik yang tersedia 24 jam penuh	Semua area Rumah Sakit - IPSRS	Form monitoring listrik dan air bersih	100 %	Air dan listrik tersedia 24 jam setiap hari dan dalam waktu 7 hari dalam seminggu	
54.	Pembuatan daftar inventaris sistem utilitas dan peta distribusinya	Tersedianya inventaris sistem utilitas dan peta distribusinya	Semua sistem utilitas di RS - IPSRS	Inventarisasi sistem utilitas dan peta distribusi	100%	Tersedia inventaris sistem utilitas dan peta distribusinya	
55.	Melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, serta perbaikan semua komponen utilitas yang ada di daftar inventaris	Agar terdapat laporan pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan semua sistem utilitas	Semua sistem utilitas di RS – IPSRS	Laporan pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan	100 %	Terdapat laporan pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan semua sistem utilitas	

No.	Rincian Kegiatan	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Jenis	Target/Standart	Indikator Keberhasilan	Keterangan
	dan komponen kriticalnya dan sumber alternatif			sistem utilitas			
56.	Membuat jadwal pemeriksaan, uji fungsi dan pemeliharaan semua sistem utilitas berdasar atas kriteria seperti rekomendasi dari pabrik, tingkat risiko, dan pengalaman rumah sakit	Agar pemeriksaan, uji fungsi dan pemeliharaan terjadwal dengan baik	Semua sistem utilitas di RS – IPSRS	jadwal pemeriksaa n, uji fungsi dan pemelihara an sistem utilitas	100 %	Terdapat jadwal pemeriksaan, uji fungsi dan pemeliharaan semua sistem utilitas	
57.	Pelabelan tuas-tuas kontrol pada sistem utilitas	Agar semua tuas kontrol memiliki label yang mempermudah untuk mengoperasik an	Semua label tuas kontrol – IPSRS	Dokumenta si pelabelan tuas kontrol	100 %	Tuas-tuas kontrol telah diberi label	
58.	Mengidentifikasi peralatan, sistem, serta area yang memiliki risiko paling tinggi terhadap pasien dan staf	Untuk mengidentifika si area yang berisiko terkait peralatan dan sistem terhadap pasien dan staf	Semua area di RS	Identifikasi	100%	Terdapat area berisiko terkait keselamatan dan keamanan	

No.	Rincian Kegiatan	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Jenis	Target/Standart	Indikator Keberhasilan	Keterangan
59.	Pengujian sumber cadangan atau alternatif air bersih dan listrik minimal 6 bulan sekali dan mendokumentasikan	Agar sumber air dan listrik cadangan diuji secara berkala	Semua sumber cadangan dan alternatif air bersih dan listrik	Umandok uji air bersih dan listrik	100 %	Sumber cadangan atau alternatif air bersih dan listrik telah dilakukan pengujian minimal 6 bulan sekali	
60.	Monitoring dan pemeriksaan mutu air bersih	Untuk menjaga mutu air bersih secara berkala	Air bersih	Hasil uji air bersih	100 %	Telah dilakukan pemeriksaan mutu air bersih	
61.	Monitoring dan pemeriksaan mutu air limbah	Untuk menjaga mutu air limbah secara berkala	Air Limbah	Hasil uji air limbah	100 %	Telah dilakukan pemeriksaan mutu air limbah	
63.	Pembuatan denah update terkait seluruh infrastruktur di Rumah Sakit	Untuk mengetahui denah update Rumah Sakit	Semua Area Rumah Sakit	Denah infrastruktur update di RS	100 %	Terdapat denah update terkait infrastuktur Rumah Sakit	
64.	Penambahan tangki bahan bakar genset	Untuk sumber cadangan bahan bakar pada genset	Genset Rumah Sakit	Umandok pembangunan tangka bahan bakar genset	100 %	Terdapat tangki bahan bakar genset	
65.	Pembuatan digram wiring listrik.	Untuk mengetahui semua aliran listrik di Rumah Sakit	Semua Area Rumah Sakit	Diagram wiring listrik	100 %	Terdapat diagram wiring listrik	

No.	Rincian Kegiatan	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Jenis	Target/Standart	Indikator Keberhasilan	Keterangan
66.	Pembuatan regulasi penanggulangan bencana	Sebagai pedoman dalam penanggulangan bencana	Semua Staf RS	Pedoman regulasi penanggulangan bencana	100 %	Terdapat regulasi penanggulangan bencana	
67.	Pembuatan <i>Hazard Vulnerability Analylis (HVA)</i>	Untuk mengetahui risiko bencana yang bisa terjadi di area RS	Semua risiko bencana yang bisa terjadi di RS	HVA tahun 2026	100 %	Terdapat HVA tahun 2023	
68.	Pembuatan tim penanggulangan keadaan darurat	Untuk memberntuk tim penanggulangan bencana	Tim penanggulangan bencana	SK Tim penanggulangan keadaan darurat	100 %	Terdapat tim penanggulangan keadaan darurat	
69.	Simulasi penanggulangan keadaan darurat	Untuk tanggap darurat terhadap bencana di RS	Semua Staf Rumah Sakit	Umandok simulasi penanggulangan keadaan darurat	100 %	Telah dilakukan simulasi penanggulangan keadaan darurat	
70.	Penyediaan area dekontaminasi pada Instalasi Gawat Darurat (IGD)	Untuk tempat melakukan dekontaminasi pada pasien	IGD	Supervisi APD ruang dekontaminasi IGD	100 %	Tersedia ruang dekontaminasi di IGD	
71.	Melaksanakan PCRA ketika proses renovasi, kontruksi dan demolisi	Untuk mengetahui risiko	Ketika ada konstruksi.	Form PCRA	100 %	Terlaksana PCRA ketika proses konstruksi, renovasi dan demolisi	

No.	Rincian Kegiatan	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Jenis	Target/Standart	Indikator Keberhasilan	Keterangan
		Pembangunan di area RS	renovasi atau demolisi				
72.	Pelatihan MFK terkait keselamatan	Untuk melakukan edukasi kepada staf terkait keselamatan	Seluruh Staf RS	Umandok pelatihan	100 %	Terlaksana pelatihan MFK terkait keselamatan	
73.	Pelatihan MFK terkait keamanan	Untuk melakukan edukasi kepada staf terkait keamanan	Seluruh Staf RS	Umandok pelatihan	100 %	Terlaksana pelatihan MFK terkait keamanan	
74.	Pelatihan MFK terkait pengelolaan B3 dan limbahnya	Untuk melakukan edukasi kepada staf terkait pengelolaan B3 dan limbahnya	Seluruh Staf RS	Umandok pelatihan	100 %	Terlaksana pelatihan MFK terkait pengelolaan B3 dan limbahnya	
75.	Pelatihan MFK terkait proteksi kebakaran	Untuk melakukan edukasi kepada staf terkait proteksi kebakaran	Seluruh Staf RS	Umandok pelatihan	100 %	Terlaksana pelatihan MFK terkait proteksi kebakaran	

No.	Rincian Kegiatan	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Jenis	Target/Standart	Indikator Keberhasilan	Keterangan
76.	Pelatihan MFK terkait peralatan medis	Untuk melakukan edukasi kepada staf terkait peralatan medis	Seluruh Staf RS	Umandok pelatihan	100 %	Terlaksana pelatihan MFK terkait peralatan medis	
77.	Pelatihan MFK terkait sistem utilitas	Untuk melakukan edukasi kepada staf terkait sistem utilitas	Seluruh Staf RS	Umandok pelatihan	100 %	Terlaksana pelatihan MFK terkait sistem utilitas	
78.	Pelatihan MFK terkait penanganan bencana	Untuk melakukan edukasi kepada staf terkait penanggulangan bencana	Seluruh Staf RS	Umandok pelatihan	100 %	Terlaksana pelatihan MFK terkait penanganan bencana	
79.	Pelatihan MFK kepada vendor, pekerja kontrak, relawan, pelajar, peserta didik, peserta pelatihan dan lainnya (jika ada).	Untuk melakukan edukasi kepada vendor, pekerja kontrak, relawan, pelajar, peserta didik, peserta pelatihan dan	Vendor, pekerja kontrak, relawan, pelajar, peserta didik, peserta pelatihan dan	Umandok pelatihan	100 %	Terlaksana pelatihan MFK kepada vendor, pekerja kontrak, relawan, pelajar, peserta didik, peserta pelatihan dan lainnya (jika ada).	

No.	Rincian Kegiatan	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Jenis	Target/Standart	Indikator Keberhasilan	Keterangan
		peserta didik, peserta pelatihan dan lainnya (jika ada) terkait MFK	lainnya (jika ada).				
80.	Pelatihan eksternal terkait Ahli K3 Listrik	Untuk menambah pengetahuan terkait kelistrikan kepada teknisi listrik	Teknisi Listrik	Nota dinas dan umandok pelatihan	100 %	Terlaksana pelatihan eksternal terkait Ahli K3 Listrik	
81.	Pelatihan eksternal terkait K3 Rumah Sakit	Untuk menambah keilmuan terkait K3RS	K3	Nota dinas dan umandok pelatihan	100 %	Terlaksana pelatihan eksternal terkait K3 Rumah Sakit	
82.	Pelatihan eksternal terkait Safety Driving dan Riding	Untuk menambah keilmuan terkait cara berkendara yang aman	All staf	umandok pelatihan	100 %	Terlaksana pelatihan eksternal terkait eksternal terkait Safety Driving dan Riding	

3.3 Cara Melaksanakan Kegiatan

No.	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan	Metode	Media	Jadwal	Bukti Pelaksanaan	Keterangan
1.	Pengarsipan dan administrasi terkait regulasi di Rumah Sakit	1. Koordinasi dengan Sekretaris RS dan sekretaris akreditasi untuk melengkapi terkait regulasi di Rumah Sakit; 2. Melakukan pengarsipan regulasi rumah sakit yang berkaitan dengan K3RS dan MFK	-	-	Insidentil	Regulasi RS	
2.	Pengarsipan dan administrasi terkait perizinan di Rumah Sakit	1. Koordinasi dengan Sekretaris RS dan bagian legalitas PT. DPM untuk melengkapi terkait regulasi di Rumah Sakit; 2. Melakukan pengarsipan regulasi rumah sakit yang berkaitan dengan K3RS dan MFK	-	-	Insidentil	Semua legalitas dan perizinan Rumah Sakit	
3.	Manajemen risiko fasilitas, keselamatan dan keamanan dan berkaitan dengan MFK	1. Melakukan rapat koordinasi dengan Komite Mutu, Komite PPI dan unit terkait untuk melakukan identifikasi risiko, penilaian risiko dan upaya pengendalian risiko; 2. Melakukan pemantauan terkait manajemen risiko.	Rapat Unit	Tabel Risk Register	Insidentil – Januari 2026	<i>Risk Register 2026</i>	

No.	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan	Metode	Media	Jadwal	Bukti Pelaksanaan	Keterangan
4.	Penyediaan handrail di kamar mandi pasien	1. Melakukan supervisi terkait penyediaan sarana handrail di Rumah Sakit; 2. Berkoordinasi dengan IPSRS terkait perbaikan atau penggantian handrail apabila diperlukan	Supervisi	Form SP Barang	Insidentil	Kegiatan pemasangan/ perbaikan <i>handrail</i> oleh IPSRS	
5.	Penyediaan <i>side rail</i> di bed pasien berfungsi dengan baik	1. Melakukan supervisi terkait penyediaan sarana <i>side rail</i> di Rumah Sakit; 2. Berkoordinasi dengan IPSRS terkait perbaikan atau penggantian <i>side rail</i> apabila diperlukan	Supervisi	Form SP Barang	Insidentil	Kegiatan pemasangan/ perbaikan <i>siderail</i> oleh IPSRS	
6.	Penyediaan APD di rumah sakit	1. Berkoordinasi dengan Komite PPI dan unit terkait untuk penyediaan APD di unit terkait; 2. Penyediaan APD sesuai kebutuhan unit	Supervisi Wawancara	Form SP Barang	Insidentil	Terdapat APD di unit	
7.	Mapping area berisiko keselamatan	1. Melakukan koordinasi dengan unit terkait untuk melakukan mapping area berisiko keselamatan ; 2. melakukan mapping area berisiko keselamatan; 3. Melakukan upaya mitigasi risiko terkait area berisiko keselamatan	Observasi	-	Februari 2026	Terdapat mapping area berisiko keselamatan	

No.	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan	Metode	Media	Jadwal	Bukti Pelaksanaan	Keterangan
8.	Melakukan supervisi terkait sarana dan prasarana (ronde fasilitas)	1. Berkoordinasi dengan bagian IPSRS terkait supervisi sarana dan prasarana di area Rumah Sakit; 2. Melakukan upaya perbaikan segera jika ditemukan sarana yang mengalami kerusakan.	Supervisi	-	Setiap Bulan	Terdapat supervisi terkait sarana dan prasarana	
9.	<i>Medical Check Up (MCU)</i> secara Berkala pada Seluruh Karyawan	1. Pembuatan TOR MCU berkala staf ; 2. Meminta persetujuan PT.DPM; untuk pelaksanaan; 3. Jika disetujui, maka laksanakan MCU berkala pada staf.	Pemeriksaan Kesehatan dan Lab	-	Maret 2026 - Mei 2026	Terdapat hasil MCU staf dan umandok MCU	
10.	<i>Rectal Swab</i> pada penjamah makanan	1. Permintaan rectal swab pada penjamah makanan; 2. Meminta persetujuan PT.DPM untuk pelaksanaan; 3. Jika disetujui, maka laksanakan rectal swab pada penjamah makanan.	Pemeriksaan Kesehatan dan Lab		Juni 2026 – Desember 2026	Terdapat hasil rectal swab penjamah makanan	
11.	Senam Kesehatan Jumat Berkah	1. Melakukan koordinasi dengan sub program geriatri dan PKRS terkait	-	-	Setiap Hari Jumat	Terdapat umandok senam	

No.	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan	Metode	Media	Jadwal	Bukti Pelaksanaan	Keterangan
		senam kesehatan setiap jumat; 2. Pembuatan TOR senam kesehatan ; 3. Meminta persetujuan PT.DPM untuk pelaksanaan; 4. Jika disetujui, maka dilaksanakan senam kesehatan pada staf.					
12.	Futsal bagi Karyawan Laki-Laki	1. Melakukan koordinasi dengan PKRS terkait futsal karyawan laki-laki 2. Pembuatan TOR futsal. 3. Meminta persetujuan PT.DPM untuk pelaksanaan 4. Jika disetujui, maka dilaksanakan futsal pada staf.	-	-	Setiap Hari Rabu	Terdapat umandok futsal	
13.	Badminton bagi Staf	1. Melakukan koordinasi dengan PKRS terkait badminton pada staf; 2. Pembuatan TOR badminton; 3. Meminta persetujuan PT.DPM untuk pelaksanaan;	-	-	Setiap Hari Rabu	Terdapat umandok badminton	

No.	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan	Metode	Media	Jadwal	Bukti Pelaksanaan	Keterangan
		4. Jika disetujui, maka dilaksanakan badminton pada staf.					
14.	Hipnoterapi pada Staf	1. Melakukan koordinasi dengan PKRS terkait hipnoterapi pada staf; 2. Pembuatan TOR hipnoterapi pada staf; 3. Meminta persetujuan PT.DPM untuk pelaksanaan; 4. Jika disetujui, maka dilaksanakan hipnoterapi pada staf.	-	-	Setiap 6 bulan sekali	Terdapat umandok hipnoterapi	
15.	Pemberian vitamin bagi staf	1. Permintaan booster kepada PT. DPM; 2. Distribusi vitamin ke semua unit; 3. Pendokumentasian dan pengarsipan dokumen.	-	-	Juni 2026	Terdapat umandok pemberian vitamin bagi staf	
16.	Pemberian makanan tambahan bagi seluruh staf setiap Hari Jumat	1. Berkoordinasi dengan bagian gizi dan dapur untuk pemberian makanan tambahan pada seluruh staf di hari Jumat ; 2. Pelaksanaan kegiatan pemberian makanan tambahan.	-	-	Setiap Jumat	-	

No.	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan	Metode	Media	Jadwal	Bukti Pelaksanaan	Keterangan
17.	Pemberian makanan tambahan bagi staf Radiologi	1. Berkoordinasi dengan bagian gizi dan dapur untuk pemberian makanan tambahan pada staf Radiologi; 2. Pelaksanaan kegiatan pemberian makanan tambahan untuk staf Radiologi.	-	-	Setiap Hari	-	
18.	Pemberian fasilitas BPJS TK bagi staf	1. Berkoordinasi dengan bagian SDM untuk pemberian BPJS TK pada staf baru; 2. Pelaksanaan pemberian BPJS TK pada staf baru.	-	-	Setiap Bulan (selesai masa orientasi)	Data BPJS TK Staf di SDM RS	
19.	Pemberian vaksin hepatitis bagi staf yang berada di area risiko tinggi misalnya IKO, ICU, IGD, Laboratorium, Maternitas, Perinatologi, IRJA, IRNA, Petugas B3, CSSD dan Laundry dan Petugas <i>Cleaning Service</i> (CS).	1. Berkoordinasi dengan Komite PPI untuk mengkaji staf berisiko tinggi di area berisiko; 2. Pengajuan TOR ke bagian PT. DPM; 3. Jika diacc, maka dilaksanakan proses koordinasi dengan penyedia vaksin; 4. Jika stok vaksin telah ada, maka dilakukan pelaksanaan vaksinasi hepatitis.	-	-	Maret 2026- Mei 2026	Terdapat umandok terkait pemberian vaksin hepatitis	

No.	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan	Metode	Media	Jadwal	Bukti Pelaksanaan	Keterangan
20..	Pemberian identitas (<i>badge</i> nama sementara atau tetap) pada pasien, staf, pekerja kontrak, tenant (penyewaan lahan), keluarga (penunggu pasien) atau pengunjung (pengunjung diluar jam besuk dan tamu RS	1. Koordinasi dengan kepala security dan bagian umum; 2. Melakukan monitoring dan supervisi secara berkala	-	-	Insidentil	Terdapat data nametag karyawan, vendor, dll	
21	Pemeriksaan dan pemantauan fasilitas dan lingkungan melalui CCTV selama 24 jam oleh petugas security dalam menghindari risiko keamanan	1. Koordinasi dengan kepala security; 2. Melakukan monitoring dan supervisi secara berkala; 3. Melaporkan hasil di form monitoring CCTV.	Observasi CCTV	-	Setiap Hari	Terdapat form monitoring CCTV	
22.	Pemeriksaan dan pemantauan fasilitas dan lingkungan melalui patroli keamanan oleh petugas security.	1. Koordinasi dengan kepala security; 2. Melakukan monitoring dan supervisi secara berkala; 3. Melaporkan hasil di form patroli keamanan	Observasi ke Lapangan	-	Setiap Hari	Terdapat hasil patrol keamanan oleh security	
23.	Pengelolaan risiko kekerasan, kejahatan dan acaman dilingkungan Rumah Sakit	1. Koordinasi dengan security dan bagian umum 2. Melakukan monitoring dan supervisi secara berkala	Observasi ke Lapangan	-	Setiap Hari	Terdapat hasil patroli keamanan dan monitoring CCTV oleh security	
24.	Pembuatan Panduan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbahnya secara <i>update</i>	Pembuatan Panduan Bahan Berbahaya dan Beracun dan limbahnya.	Supervisi Pengkajian dari regulasi	Pedoman	Februari 2026	Terdapat pedoman B3 dan limbahnya	

No.	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan	Metode	Media	Jadwal	Bukti Pelaksanaan	Keterangan
			yang berlaku				
25.	Inventarisasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbahnya yang meliputi jenis, jumlah, simbol dan lokasi	Berkoordinasi dengan petugas Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan unit terkait untuk melakukan inventarisasi data.	Supervisi Observasi	-	Setiap Bulan	Terdapat inventaris B3 dan limbahnya	
26.	Penanganan, penyimpanan dan penggunaan B3 dan limbahnya	1. Pembuatan panduan B3 dan limbahnya dan SPO terkait penanganan, penyimpanan dan penggunaan B3 dan limbahnya ; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait penanganan, penyimpanan dan penggunaan B3 dan limbahnya.	Supervisi Observasi	-	Insidentil	Terdapat <i>logbook</i> limbah B3, inventaris B3 dan SPO terkait	
27.	Pelatihan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan prosedur bila terjadi tumpahan paparan/pajanan (<i>spill kit</i> dan <i>eye washer</i>)	1. Berkoordinasi dengan PPI terkait pelatihan penggunaan APD khususnya apabila terjadi tumpahan atau pajanan ; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus.	Diskusi Kelompok	Review SPO	Mei 2026	Terdapat umandok pelatihan penggunaan APD	

No.	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan	Metode	Media	Jadwal	Bukti Pelaksanaan	Keterangan
28.	Pelatihan yang dilakukan oleh staf yang menangani Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1. Berkoordinasi dengan PPI terkait pelatihan pada staf yang menangani B3 atau mengajukan pelatihan eksternal Rumah Sakit; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus.	Diskusi Kelompok	PPT	September 2026	Terdapat umandok pelatihan penanganan B3	
29.	Pemberian label/rambu-rambu yang tepat pada B3 dan limbahnya	1. Berkoordinasi dengan petugas B3, Cleaning Service dan Unit yang terdapat B3 untuk melakukan pemberian label atau simbol pada B3 ; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pemberian label/rambu B3 dan simbolnya.	Praktek	Simbol Label	Setiap hari	Terdapat dokumentasi label/ rambu pada B3	
30.	Pelaporan dan investigasi dari tumpahan, eksposur (terpapar) dan insiden lainnya, dimana termasuk pemenuhan spill kit	1. Berkoordinasi dengan PPI terkait alur pelaporan investigasi terhadap tumpahan atau insiden lainnya dan pemenuhan spill kit ; 2. Melakukan sosialisasi secara berkala ; 3. Melakukan monitoring evaluasi	Supervisi Observasi	Pelaporan tumpahan B3	Insidentil	Terdapat pelaporan investigasi atau tumpahan atau pajanan	

No.	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan	Metode	Media	Jadwal	Bukti Pelaksanaan	Keterangan
31.	Pengarsipan dokumentasi, termasuk izin, lisensi, atau persyaratan peraturan lainnya	1. Berkoordinasi dengan sekretaris Rumah Sakit ; 2. Melakukan pengarsipan dokumentasi terkait izin, lisensi dan persyaratan peraturan lainnya terkait Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)	-	-	Insidentil	Terdapat Tersedia umandok terkait vendor B3	
32.	Melampirkan Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) atau <i>Material Safety Data Sheet (MSDS)</i> ketika pengadaan/pembelian B3 dan pemasok (supplier).	1. Berkoordinasi dengan bagian pengadaan farmasi terkait lampiran MSDS pada setiap pembelian B3 ; 2. Pengarsipan MSDS; 3. Pendistribusian kepada unit terkait	Supervisi Observasi	MSDS	Insidentil	Data MSDS pada Gudang Farmasi dan Unit yang penyimpanan B3	
33.	Melakukan penyimpanan limbah di TPS B3 sesuai aturan yang berlaku	1. Berkoordinasi dengan petugas B3 dan vendor PPI. 2. Melakukan ceklish setiap bulannya untuk TPS B3	Supervisi	Form Supervisi TPS B3	Setiap Bulan	Form monitoring TPS B3	
34.	Pengukuran pH dan debit air limbah	1. Berkoordinasi dengan petugas B3 dan PPI; 2. Melakukan pengukuran pH dan debit air limbah	Supervisi	Form pengukuran pH dan debit air limbah	Setiap hari	Form pengukuran pH dan debit air limbah	

No.	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan	Metode	Media	Jadwal	Bukti Pelaksanaan	Keterangan
35.	Melakukan pengolahan limbah B3 dengan pihak ketiga sesuai Mou yang berlaku	1. Melakukan koordinasi dengan legalitas PT DPM untuk mengupdate MoU pengolahan limbah 2. Melakukan koordinasi dengan Komite PPI dan petugas B3 untuk melakukan koordinasi dengan transporter yang menjadi pihak kedua RS Prima Husada	Koordinasi	Cetak	Maksima 1 2 hari sekali	Form manifest pengolahan limbah B3	
36.	Penyimpanan dan penanganan bahan mudah terbakar secara aman termasuk gas-gas medis yang mudah terbakar dengan pemasangan rantai dan pengaman lainnya	1. Berkoordinasi dengan ATEM terkait penyimpanan dan penanganan bahan mudah terbakar khususnya gas medis; 2. Melakukan perancangan dan penataan agar bahan bahan tersebut tidak menimbulkan adanya kebakaran dilingkungan Rumah Sakit; 3. Penyediaan APAR dan alat penanggulangan kebakaran lainnya di area yang berisiko kebakaran.	Supervisi Observasi	-	Setiap hari	Dokumentasi terkait Penyimpanan dan penanganan bahan mudah terbakar secara aman termasuk gas-gas medis yang mudah terbakar dengan pemasangan rantai dan pengaman lainnya	
37.	Pengendalian potensi bahaya dan risiko kebakaran yang terkait dengan konstruksi	1. Mengidentifikasi area berisiko kebakaran ;	Supervisi Observasi	-	Setiap hari	Pembangunan konstruksi tahan api	

No.	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan	Metode	Media	Jadwal	Bukti Pelaksanaan	Keterangan
	apapun di atau yang berdekatan dengan bangunan yang ditempati pasien	2. Melakukan upaya pengendalian dengan menempatkan APAR dan alat penanggulangan kebakaran lainnya di area tersebut ; 3. Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap alat-alat pemadam api dengan berkoordinasi dengan unit terkait dan IPSRS.					
38.	Penyediaan rambu dan jalan keluar (evakuasi) yang aman	Melakukan pemeliharaan dan penyediaan rambu dan jalan evakuasi yang aman dengan cara berkoordinasi dengan bagian umum dan IPSRS	Supervisi Observasi	-	Setiap hari	Dokumentasi rambu evakuasi	
39.	Penyediaan dan pemeliharaan sistem peringatan dini secara pasif meliputi detector asap, detector panas, alarm kebakaran dan lain-lain	Berkoordinasi dengan IPSRS terkait penyediaan dan pemeliharaan sistem peringatan dini secara pasif meliputi detector asap, detector panas, alarm kebakaran dan lain-lain	Supervisi Observasi	-	Insidentil	Dokumentasi dan form pemeliharaan sistem peringatan dini secara pasif	
40.	Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pemadam api aktif meliputi APAR, hydrant, sistem sprinkler dan lain-lain	Berkoordinasi dengan IPSRS terkait pemeliharaan fasilitas pemadam api aktif meliputi APAR, hydrant, sistem sprinkler dan lain-lain	Supervisi Observasi	-	Insidentil	Dokumentasi dan form pemeliharaan sistem peringatan dini secara aktif	

No.	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan	Metode	Media	Jadwal	Bukti Pelaksanaan	Keterangan
41.	Pembuatan sistem pemisahan (pengisolasian) dan kompartemenisasi pengendalian api dan asap	1. Melakukan persetujuan dengan manajemen rumah sakit dan penunjukan <i>plan layout</i> dan sarana yang dipakai; 2. Jika disetujui, berkoordinasi dengan bagian umum untuk melakukan identifikasi kebutuhan pembuatan sistem pemisahan; 3. Melakukan surat permintaan kebutuhan bahan ; 4. Membuat sistem pemisahan dan kompartemenisasi pengendalian api dan asap ; 5. Monitoring dan evaluasi	Supervisi Observasi	-	Oktober 2026	Dokumentasi Pembangunan sistem pemisahan dan kompartemenisasi pengendalian api dan asap	
42.	Inventarisasi, pemeriksaan berkala, uji coba dan pemeliharaan berkala sistem pemadam kebakaran aktif dan pasif di RS	Berkoordinasi dengan IPSRS terkait inventarisasi, pemeriksaan dan uji coba pemeriksaan berkala sistem pemadam kebakaran aktif dan pasif di Rumah Sakit	Supervisi Observasi	-	Setiap Bulan	Bukti Inventarisasi, pemeriksaan berkala, uji coba dan pemeliharaan berkala sistem pemadam kebakaran aktif dan pasif di RS	

No.	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan	Metode	Media	Jadwal	Bukti Pelaksanaan	Keterangan
43.	Identifikasi area berisiko kebakaran	1. Melakukan identifikasi area berisiko kebakaran di Rumah Sakit; 2. Melakukan penilaian dan pengendalian terkait area berisiko kebakaran.	Supervisi Observasi	-	Setiap 6 bulan sekali	Bukti Identifikasi area berisiko kebakaran	
44.	Simulasi kebakaran minimal setahun sekali	1. Pembuatan TOR simulasi kebakaran ; 2. Berkoordinasi dengan tim terkait ; 3. Melakukan simulasi kebakaran ; 4. Mengarsipkan umandok dari simulasi kebakaran	Praktek	SOP simulasi kebakaran	Oktober 2026	Umandok simulasi kebakaran	
45.	Monitoring pelaksanaan monitoring Kawasan Tanpa Merokok (KTR).	1. Berkoordinasi dengan security terkait patroli Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Rumah Sakit ; 2. Pengarsipkan hasil patrol; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi;	Supervisi Observasi	Form KTR	Setiap Hari	Form monitoring KTR	
46.	Identifikasi penilaian kebutuhan peralatan medis beserta uji fungsi	1. Berkoordinasi dengan ATEM terkait pembuatan identifikasi penilaian kebutuhan peralatan medis ; 2. Pembuatan identifikasi penilaian kebutuhan peralatan medis;	Audit	Form Identifikasi peralatan medis	Januari 2026 Juli 2026	Identifikasi peralatan medis	

No.	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan	Metode	Media	Jadwal	Bukti Pelaksanaan	Keterangan
		3. Melakukan monitoring dan evaluasi					
47.	Inventarisasi peralatan medis baik yang KSO ataupun yang Non-KSO	1. Berkoordinasi dengan ATEM ; 2. Melakukan inventarisasi peralatan medis ; 3. Melakukan pengarsipan hasil inventaris peralatan medis	Supervisi	Form inventaris peralatan medis	Setiap Bulan	Inventarisasi peralatan medis	
48.	Melakukan uji fungsi pada peralatan medis baru	1. Berkoordinasi dengan ATEM ; 2. Melakukan inventarisasi peralatan medis ; 3. Melakukan pengarsipan hasil inventaris peralatan medis	Dokumentasi	Form umandok dan materi dan vendor alkes	Kondisional	Umandok uji fungsi peralatan medis	
49.	Pemeriksaan peralatan medis	1. Berkoordinasi dengan ATEM ; 2. Melakukan pemeriksaan peralatan medis; 3. Melakukan pengarsipan hasil pemeriksaan peralatan medis	Supervisi	Form pemeriksaan peralatan medis	Setiap Bulan		
50.	Pengujian peralatan medis	1. Berkoordinasi dengan ATEM ; 2. Melakukan pengujian peralatan medis;	Supervisi	Form Pengujian alkes	Setiap 1 bulan sekali	Umandok pengujian peralatan medis	

No.	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan	Metode	Media	Jadwal	Bukti Pelaksanaan	Keterangan
		3. Melakukan pengujian hasil pemeriksaan peralatan medis					
51.	Pemeliharaan preventif dan kalibrasi peralatan medis	1. Berkoordinasi dengan ATEM ; 2. Melakukan pendataan alat sesuai jadwal kalibrasi; 3. Melakukan permintaan ke PT. DPM terkait kalibrasi alkes; 4. Pelaksanaan kalibrasi alkes; 5. Mengarsipkan dokumentasi dan sertifikat kalibrasi	Supervisi	Tablet pemeliharaan alkes	Agustus 2026 / Setahun sekali	Form pemeliharaan preventif dan sertifikat kalibrasi peralatan medis	
52.	Pemantauan, pemberitahuan kerusakan (malfungsi) dan penarikan (<i>recall</i>) peralatan medis yang membahayakan pasien	1. Berkoordinasi dengan ATEM ; 2. Menyosialisasikan terkait SPO <i>recall</i> dan kerusakan peralatan medis.; 3. Melakukan pemantauan pemberitahuan apabila terdapat kerusakan atau penarikan kembali peralatan medis; 4. Melakukan pengarsipan hasil apabila terdapat alkes yang rusak atau dilakukan recall.	Supervisi	Form <i>Recall</i> Alkes	Kondisional	Form <i>Recall</i> Alkes	

No.	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan	Metode	Media	Jadwal	Bukti Pelaksanaan	Keterangan
53.	Memastikan ketersediaan air dan listrik 24 jam setiap hari dan dalam waktu 7 hari dalam seminggu	Berkoordinasi dengan IPSRS terkait penyediaan air dan listrik 24 jam setiap hari dan dalam waktu 7 hari dalam seminggu	Pencatatan dan Supervisi	-	Setiap hari	Form pemantauan panel Listrik dan debit air bersih	
54.	Pembuatan daftar inventaris sistem utilitas dan peta distribusinya	1. Berkoordinasi dengan IPSRS terkait pembuatan daftar inventaris, dan lokasi sistem utilitas berada; 2. Pelaksanaan pembuatan daftar inventaris dan peta distribusinya; 3. Pembuatan peta pendistribusian dan daftar inventaris sistem utilitas; 4. Pengarsipan hasil pembuatan daftar inventaris, perbaikan dan pemeliharaan, inspeksi dan pengujian sistem utilitas	Observasi	Daftar Inventaris Sistem Utilitas dan peta distribusi sistem utilitas	Januari 2026	Inventaris sistem utilitas dan peta distribusi sistem utilitas	
55.	Melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, serta perbaikan semua komponen utilitas yang ada di daftar inventaris dan komponen kritikalnya dan sumber alternatif	1. Berkoordinasi dengan IPSRS terkait pemeriksaan, pemeliharaan serta perbaikan sistem utilitas; 2. Pelaksanaan pemeriksaan,	Supervisi	Form pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan	Setiap hari	Form pemeriksaan, pemeliharaan serta perbaikan sistem utilitas;	

No.	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan	Metode	Media	Jadwal	Bukti Pelaksanaan	Keterangan
		pemeliharaan serta perbaikan sistem utilitas; 3. Pengarsipan hasil pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan sistem utilitas		sistem utilitas			
56.	Membuat jadwal pemeriksaan, uji fungsi dan pemeliharaan semua sistem utilitas berdasar atas kriteria seperti rekomendasi dari pabrik, tingkat risiko, dan pengalaman rumah sakit	1. Berkoordinasi dengan IPSRS terkait pemeriksaan, uji fungsi dan pemeliharaan sistem utilitas; 2. Pelaksanaan pemeriksaan, uji fungsi dan pemeliharaan sistem utilitas; 3. Pengarsipan hasil pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan sistem utilitas	Supervisi	Jadwal pemeriksaan, uji fungsi dan pemeliharaan	Setiap hari	Jadwal pemeriksaan, uji fungsi dan pemeliharaan	
57.	Pelabelan tuas-tuas kontrol pada sistem utilitas	1. Berkoordinasi dengan IPSRS terkait pelabelan pada tuas-tuas kontrol di panel listrik; 2. Mendokumentasikan hasil pelabelan tuas-tuas kontrol	Supervisi	Label Tuas Kontrol	Setiap hari	Dokumentasi tuas-tuas kontrol yang diberi label	

No.	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan	Metode	Media	Jadwal	Bukti Pelaksanaan	Keterangan
58.	Mengidentifikasi peralatan, sistem, serta area yang memiliki risiko paling tinggi terhadap pasien dan staf	1. Melakukan observasi dan kajian dengan unit-unit terkait untuk menentukan area berisiko terkait keselamatan dan keamanan fasilitas 2. Melakukan pembuatan sk area berisiko 3. Melakukan pengendalian risiko terkait hasil observasi	Observasi	Form observasi	Januari 2026	SK Pengkajian Area Berisiko	
59.	Pengujian sumber cadangan atau alternatif air bersih dan listrik minimal 6 bulan sekali	1. Berkoordinasi dengan IPSRS dan vendor terkait; 2. Pelaksanaan pengujian air bersih dan listrik ; 3. Melakukan dokumentasi hasil pengujian sumber cadangan air bersih atau listrik	Praktek	-	Juni 2026 Desember 2026	Umandok pengujian sumber cadangan atau alternatif air atau listrik	
60.	Monitoring dan pemeriksaan mutu air bersih	1. Melakukan koordinasi dengan petugas yang berkaitan air bersih ; 2. Melakukan penjadwalan pemeriksaan mutu air bersih dengan vendor terkait ; 3. Meminta surat penawaran harga ; 4. Melakukan permintaan persetujuan;	Pemeriksaan/ Uji Lab	-	Setiap Bulan	Hasil mutu air bersih	

No.	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan	Metode	Media	Jadwal	Bukti Pelaksanaan	Keterangan
		5. Apabila disetujui, dilaksanakan pemeriksaan mutu air bersih ; 6. Pengarsipan hasil pemeriksaan mutu air bersih.					
61.	Monitoring dan pemeriksaan mutu air limbah	1. Melakukan koordinasi dengan petugas IPAL; 2. Melakukan penjadwalan pemeriksaan mutu air limbah dengan vendor terkait ; 3. Meminta surat penawaran harga ; 4. Melakukan permintaan persetujuan; 5. Apabila disetujui, dilaksanakan pemeriksaan mutu air limbah; 6. Pengarsipan hasil pemeriksaan mutu air limbah	Pemeriksaan/ Uji Lab	-	Setiap Bulan	Hasil mutu air limbah	
62.	Monitoring pemeriksaan mutu air yang digunakan untuk dialisis ginjal setiap bulan untuk menilai pertumbuhan bakteridan endotoksin	1. Melakukan koordinasi dengan vendor terkait dan IPSRS; 2. Melakukan penjadwalan pemeriksaan mutu air RO dengan vendor terkait ;	Pemeriksaan/ Uji Lab	-	Setiap Bulan	Hasil mutu air RO	

No.	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan	Metode	Media	Jadwal	Bukti Pelaksanaan	Keterangan
		3. Meminta surat penawaran harga ; 4. Melakukan permintaan persetujuan; 5. Apabila disetujui, dilaksanakan pemeriksaan mutu air endotoksin 6. Pengarsipan hasil pemeriksaan mutu air endotoksin					
63.	Pembuatan denah update terkait seluruh infrastruktur di Rumah Sakit	1. Meminta persetujuan pembuatan denah update di seluruh area Rumah Sakit; 2. Apabila disetujui, maka dilakukan pembuatan denah diseluruh area Rumah Sakit ; 3. Pengarsipan hasil	-	-	Feb 2026	Denah update terkait seluruh infrastruktur di Rumah Sakit	
64.	Penambahan tangki bahan bakar genset	1. Meminta surat permintaan penawaran kepada vendor terkait ; 2. Melakukan permintaan persetujuan kepada manajemen; 3. Apabila disetujui, maka dilaksanakan penambahan tangki bahan bakar genset ;	-	-	Maret 2026	Umandok pemasangan tangka bahan bakar genset	

No.	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan	Metode	Media	Jadwal	Bukti Pelaksanaan	Keterangan
		4. Pemeliharaan tangki bahan bakar genset					
65.	Pembuatan diagram wiring listrik.	1. Meminta persetujuan pembuatan diagram wiring listrik di seluruh area Rumah Sakit; 2. Apabila disetujui, maka dilakukan pembuatan denah diagram wiring listrik diseluruh area Rumah Sakit ; 3. Pengarsipan hasil	-	-	Agustus 2026	Diagram wiring listrik.	
66.	Pembuatan regulasi penanggulangan bencana	1. Berkoordinasi dengan tim penanggulangan bencana terkait pembuatan regulasi terkait penanggulangan bencana; 2. Pembuatan pedoman penanggulangan bencana; 3. Pengarsipan pedoman penanggulangan bencana	Rapat Komite	-	Januari 2026	Adanya pedoman penanggulangan bencana	
67.	Pembuatan <i>Hazard Vulnerability Analylis (HVA)</i>	1. Berkoordinasi dengan tim penanggulangan bencana terkait pembuatan <i>Hazard Vulnerability Analylis (HVA)</i> ;	Rapat Komite	-	Januari 2026	Adanya HVA Tahun 2026	

No.	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan	Metode	Media	Jadwal	Bukti Pelaksanaan	Keterangan
		2. Pembuatan <i>Hazard Vulnerability Analylis (HVA)</i> ; 3. Pengarsipan <i>Hazard Vulnerability Analylis (HVA)</i>					
68.	Pembuatan tim penanggulangan keadaan darurat	1. Berkoordinasi dengan tim penanggulangan bencana terkait pembuatan SK tim penanggulangan bencana; 2. Pembuatan SK tim penanggulangan bencana; 3. Pengarsipan SK tim penanggulangan bencana	Rapat Komite	-	Januari 2026	Adanya SK Tim Penanggulangan Bencana	
69.	Simulasi penanggulangan keadaan darurat	1. Berkoordinasi dengan tim penanggulangan bencana terkait penjadwalan dilakukan simulasi penanggulangan bencana; 2. Pembuatan TOR simulasi penanggulangan keadaan darurat; 3. Pelaksanaan simulasi penanggulangan keadaan darurat; 4. Monitoring dan evaluasi ;	Sosialisasi dan Praktek	PPT dan Praktek	Oktober 2026	Umandok Simulasi Penanggulangan Keadaan Darurat	

No.	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan	Metode	Media	Jadwal	Bukti Pelaksanaan	Keterangan
		5. Pengarsipan dokumentasi simulasi penanggulangan keadaan darurat					
70.	Penyediaan area dekontaminasi pada Instalasi Gawat Darurat (IGD)	Berkoordinasi dengan Kepala IGD terkait penyediaan area dekontaminasi dan pemeliharaan sarana yang ada di area dekontaminasi	Supervisi	-	Setiap waktu	Dokumentasi Area Dekontaminasi	
71.	Melaksanakan PCRA ketika proses renovasi, kontruksi dan demolisi	1. Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan PCRA kepada bagian umum ; 2. Melakukan PCRA apabila terdapat renovasi, konstruksi dan demolisi; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi	Supervisi	Form PCRA	Insidentil / Kondisional	Dokumentasi PCRA	
72.	Pelatihan MFK terkait keselamatan	1. Pembuatan TOR pelatihan MFK ; 2. Pelaksanaan pelatihan MFK ; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi ; 4. Melakukan pengarsipan data terkait umandok pelatihan	Sosialisai/ Pitstop/ Simulasi	PPT	Juni – Juli 2026	Umandok pelatihan	
73.	Pelatihan MFK terkait keamanan	1. Pembuatan TOR pelatihan MFK ;	Sosialisai/ Pitstop/ Simulasi	PPT	Juni – Juli 2026	Umandok pelatihan	

No.	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan	Metode	Media	Jadwal	Bukti Pelaksanaan	Keterangan
		2. Pelaksanaan pelatihan MFK ; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi ; 4. Melakukan pengarsipan data terkait umandok pelatihan					
74.	Pelatihan MFK terkait pengelolaan B3 dan limbahnya	1. Pembuatan TOR pelatihan MFK ; 2. Pelaksanaan pelatihan MFK ; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi ; 4. Melakukan pengarsipan data terkait umandok pelatihan	Sosialisai/ Pitstop/ Simulasi	PPT	Juni – Juli 2026	Umandok pelatihan	
75.	Pelatihan MFK terkait proteksi kebakaran	1. Pembuatan TOR pelatihan MFK ; 2. Pelaksanaan pelatihan MFK ; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi ; 4. Melakukan pengarsipan data terkait umandok pelatihan	Sosialisai/ Pitstop/ Simulasi	PPT	Juni – Juli 2026	Umandok pelatihan	
76.	Pelatihan MFK terkait peralatan medis	1. Pembuatan TOR pelatihan MFK ; 2. Pelaksanaan pelatihan MFK ;	Sosialisai/ Pitstop/ Simulasi	PPT	Juni – Juli 2026	Umandok pelatihan	

No.	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan	Metode	Media	Jadwal	Bukti Pelaksanaan	Keterangan
		3. Melakukan monitoring dan evaluasi ; 4. Melakukan pengarsipan data terkait umandok pelatihan					
77.	Pelatihan MFK terkait sistem utilitas	1. Pembuatan TOR pelatihan MFK ; 2. Pelaksanaan pelatihan MFK ; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi; 4. Melakukan pengarsipan data terkait umandok pelatihan	Sosialisai/ Pitstop/ Simulasi	PPT	Juni – Juli 2026	Umandok pelatihan	
78.	Pelatihan MFK terkait penanganan bencana	1. Pembuatan TOR pelatihan MFK ; 2. Pelaksanaan pelatihan MFK ; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi ; 4. Melakukan pengarsipan data terkait umandok pelatihan	Sosialisai/ Pitstop/ Simulasi	PPT	Juni – Juli 2026	Umandok pelatihan	
79.	Pelatihan MFK kepada vendor, pekerja kontrak, relawan, pelajar, peserta didik, peserta pelatihan dan lainnya (jika ada).	1. Pembuatan TOR pelatihan MFK ; 2. Pelaksanaan pelatihan MFK ; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi ;	Sosialisai/ Pitstop/ Simulasi	PPT	Juni – Juli 2026	Umandok pelatihan	

No.	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan	Metode	Media	Jadwal	Bukti Pelaksanaan	Keterangan
		4. Melakukan pengarsipan data terkait umandok pelatihan					
80.	Pelatihan eksternal terkait Ahli K3 Listrik	1. Pengajuan terkait pelatihan eksternal kepihak manajemen Rumah Sakit; 2. Apabila disetujui, dilaksanakan pelatihan eksternal; 3. Pembuatan laporan hasil pelatihan; 4. Pengarsipan dokumen pelatihan	Online / Offline	-	Oktober 2026	Nota Dinas Pelatihan dan Sertifikat Pelatihan	
81.	Pelatihan eksternal terkait K3 Rumah Sakit	1. Pengajuan terkait pelatihan eksternal kepihak manajemen Rumah Sakit ; 2. Apabila disetujui, dilaksanakan pelatihan eksternal; 3. Pembuatan laporan hasil pelatihan; 4. Pengarsipan dokumen pelatihan	Online / Offline	-	Agustus 2026	Nota Dinas Pelatihan dan Sertifikat Pelatihan	
82.	Pelatihan eksternal terkait Safety Driving dan Riding	1. Pengajuan terkait pelatihan eksternal ke pihak manajemen Rumah Sakit ;	Online / Offline	-	Oktober 2026	Nota Dinas Pelatihan dan Sertifikat Pelatihan	

No.	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan	Metode	Media	Jadwal	Bukti Pelaksanaan	Keterangan
		2. Apabila disetujui, dilaksanakan pelatihan eksternal; 3. Pembuatan laporan hasil pelatihan; 4. Pengarsipan dokumen pelatihan					

3.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2026

NO	Kegiatan	Sasaran	Bulan												Tempat	PIC	Sumber Dana	Ket
			12/25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Pembuatan program kerja dan RBA tahun 2026	Tim MFK														-	-	
2.	Pengarsipan dan administrasi terkait regulasi di Rumah Sakit	Semua Regulasi di RS – Legal-Sekretaris RS														Lemari Arsip	Sekretaris RS	PT. DPM
3.	Pengarsipan dan administrasi terkait perizinan di Rumah Sakit	Semua perizinan – Legal – Sekretaris RS														Lemari Arsip	Legal PT DPM	PT. DPM
4.	Manajemen risiko fasilitas, keselamatan dan keamanan dan berkaitan dengan MFK	Semua karyawan														Masing-masing unit	Komite Mutu, K3RS dan PPI	PT. DPM

NO	Kegiatan	Sasaran	Bulan												Tempat	PIC	Sumber Dana	Ket
			12/25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
5.	Penyediaan handrail di kamar mandi pasien	Semua kamar mandi pasien														Masing-masing unit	Unit dan IPSRS	PT. DPM
6.	Penyediaan side rail di bed pasien berfungsi dengan baik	Semua bed pasien														Masing-masing unit	Unit dan IPSRS	PT. DPM
7.	Penyediaan APD di rumah sakit	Semua karyawan														Masing-masing unit	Komite K3RS dan Komite PPI	PT. DPM
8.	Mapping area berisiko keselamatan	Semua area Rumah Sakit														Seluruh area di RS	K3RS	PT. DPM
9.	Melakukan supervisi terkait sarana dan prasarana (ronde fasilitas)	Semua sarana dan prasarana														Seluruh area di RS	IPSRS	PT. DPM
10.	<i>Medical Check Up (MCU)</i> secara berkala pada seluruh karyawan	Seluruh staf														Poli MCU	Komite K3RS	PT. DPM
11.	<i>Rectal Swab</i> pada penjamah makanan	Staf Penjamah Makanan														Laboratorium	Komite K3RS	PT. DPM
12.	Senam Kesehatan Jumat Berkah	Seluruh Staf dan Lansia di area sekitar RS														Halaman Parkir RS	Komite K3RS dan Komite PKRS	PT. DPM
13.	Futsal bagi Karyawan Laki-Laki	Staf laki-laki														Lapangan Futsal	Komite K3RS dan Komite PKRS	PT. DPM

NO	Kegiatan	Sasaran	Bulan												Tempat	PIC	Sumber Dana	Ket	
			12/25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
14.	Badminton bagi Staf	Seluruh Staf														Lapangan Badminton	Komite K3RS dan Komite PKRS	PT. DPM	
15.	Hipnoterapi pada Staf	Seluruh Staf yang membutuhkan														Hall Sakura	Komite K3RS dan Komite PKRS	PT. DPM	
16.	Pemberian vitamin bagi staf	Seluruh Staf														Semua Unit	Komite K3RS	PT. DPM	
17.	Pemberian makanan tambahan bagi seluruh staf setiap Hari Jumat	Seluruh Staf														Seluruh unit	Gizi/Dapur	PT. DPM	
18.	Pemberian makanan tambahan bagi staf Radiologi	Seluruh Staf Radiologi														Unit Radiologi	Gizi/Dapur	PT. DPM	
19.	Pemberian fasilitas BPJS TK bagi staf	Seluruh Staf , non orientasi														Seluruh unit	Gizi/Dapur	PT. DPM	
20.	Pemberian vaksin hepatitis bagi staf yang berada di area risiko tinggi misalnya IKO, ICU, IGD, Laboratorium, Maternitas, Perinatologi, IRJA, IRNA, Petugas B3, CSSD dan Laundry	Staf IKO, ICU, IGD, Laboratorium, Maternitas, Perinatologi, IRJA, IRNA, Petugas B3, CSSD dan Laundry dan Petugas														Unit terkait	SDM, PPI dan K3RS	PT. DPM	

NO	Kegiatan	Sasaran	Bulan												Tempat	PIC	Sumber Dana	Ket
			12/25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	dan Petugas <i>Cleaning Service</i> (CS).	<i>Cleaning Service</i> (CS).																
21.	Pemberian identitas (<i>badge</i> nama sementara atau tetap) pada pasien, staf, pekerja kontrak, tenant (penyewa lahan), keluarga (penunggu pasien) atau pengunjung (pengunjung diluar jam besuk dan tamu RS	Pasien, staf, pekerja kontrak, tenant (penyewa lahan), keluarga (penunggu pasien) atau pengunjung (pengunjung diluar jam besuk dan tamu RS														Semua unit	Security/ Kepala Umum/ Kepala SDM	PT. DPM
22.	Pemeriksaan dan pemantauan fasilitas dan lingkungan melalui CCTV selama 24 jam oleh petugas security dalam menghindari risiko keamanan	Semua Area Rumah Sakit kecuali kamar pasien dan area privasi pasien														Semua unit	Security	PT. DPM
23.	Pemeriksaan dan pemantauan fasilitas dan lingkungan melalui patroli keamanan oleh petugas security.	Semua area RS – Security														Semua unit	Security	PT. DPM

NO	Kegiatan	Sasaran	Bulan												Tempat	PIC	Sumber Dana	Ket	
			12/25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
24.	Pengelolaan risiko kekerasan, kejahatan dan acaman dilingkungan Rumah Sakit	Semua Staf														Hall Sakura	Kepala Security	PT. DPM	
25.	Pembuatan Panduan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbahnya secara <i>update</i>	Seluruh B3 dan limbahnya – Seluruh Unit														-	Tim MFK dan B3	PT. DPM	
26.	Inventarisasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbahnya yang meliputi jenis, jumlah, simbol dan lokasi	Agar semua B3 dan limbahnya mampu terinventarisasi dengan baik														Gudang B3 dan unit terkait	Farmasi	PT. DPM	
27.	Penanganan, penyimpanan dan penggunaan B3 dan limbahnya	Semua B3 dan limbahnya														Gudang B3 dan unit terkait	Farmasi	PT. DPM	
28.	Pelatihan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan prosedur bila terjadi tumpahan paparan/pajanan (<i>spill kit</i> dan <i>eye washer</i>)	Semua Staf														Semua unit	Komite PPI	PT. DPM	
29.	Pelatihan yang dilakukan oleh staf	Semua Staf														Semua unit	Farmasi	PT. DPM	

NO	Kegiatan	Sasaran	Bulan												Tempat	PIC	Sumber Dana	Ket
			12/25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	yang menangani Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)																	
30.	Pemberian label/rambu-rambu yang tepat pada B3 dan limbahnya	Semua B3 dan limbahnya														Gudang B3	Famasi	PT. DPM
31.	Pelaporan dan investigasi dari tumpahan, eksposur (terpapar) dan insiden lainnya, dimana termasuk pemenuhan spill kit	Semua staf														Semua unit	Komite PPI	PT. DPM
32.	Pengarsipan dokumentasi, termasuk izin, lisensi, atau persyaratan peraturan lainnya	Semua vendor terkait B3 yang melakukan MoU dengan RS														Vendot terkait	Komite PPI, MFK	PT. DPM
33.	Melampirkan Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) atau <i>Material Safety Data Sheet (MSDS)</i> ketika pengadaan/pembelian B3 dan pemasok (supplier).	Semua unit yang melakukan penyimpanan B3														Gudang Famasi	Farmasi	PT. DPM
34.	Melakukan penyimpanan limbah	Limbah padat B3														TPS B3	Pengolah B3	PT. DPM

NO	Kegiatan	Sasaran	Bulan												Tempat	PIC	Sumber Dana	Ket
			12/25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	di TPS B3 sesuai aturan yang berlaku																	
35.	Pengukuran pH dan debit air limbah	Air limbah														IPAL	Pengolah B3	PT. DPM
36.	Melakukan pengolahan limbah B3 dengan pihak ketiga sesuai Mou yang berlaku	Limbah padat B3														Vendor masing-masing	Pengolah B3	PT. DPM
37.	Penyimpanan dan penanganan bahan bahan mudah terbakar secara aman termasuk gas-gas medis yang mudah terbakar dengan pemasangan rantai dan pengaman lainnya	Gudang Penyimpanan B3 dan Gas Medis														Gas Medis dan unit berisiko	K3RS	PT. DPM
38.	Pengendalian potensi bahaya dan risiko kebakaran yang terkait dengan konstruksi apapun di atau yang berdekatan dengan bangunan yang ditempati pasien	Jalur keluar menuju titik kumpul														Semua unit	K3RS	PT. DPM

NO	Kegiatan	Sasaran	Bulan												Tempat	PIC	Sumber Dana	Ket
			12/25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
39.	Penyediaan rambu dan jalan keluar (evakuasi) yang aman	Rambu evakuasi, titik kumpul dan pintu keluar (Rambu untuk Proses evakuasi)														Semua area di RS	K3RS dan Umum	PT. DPM
40.	Penyediaan dan pemeliharaan sistem peringatan dini secara pasif meliputi detector asap, detector panas, alarm kebakaran dan lain-lain	Seluruh bangunan di RS yang berisiko kebakaran														Semua area di RS	K3RS dan Umum	PT. DPM
41.	Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pemadam api aktif meliputi APAR, hydrant, sistem sprinkler dan lain-lain	Seluruh bangunan di RS yang berisiko kebakaran														Semua area di RS	K3RS dan Umum	PT. DPM
42.	Pembuatan sistem pemisahan (pengisolasian) dan kompartemenisasi pengendalian api dan asap	Seluruh bangunan di RS yang berisiko kebakaran														Semua area di RS	K3RS dan Umum	PT. DPM
43.	Inventarisasi, pemeriksaan berkala, uji coba dan	Semua sistem penanggulangan kebakaran														Semua area di RS	IPSRS, Security, K3RS	PT. DPM

NO	Kegiatan	Sasaran	Bulan													Tempat	PIC	Sumber Dana	Ket
			12/25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	pemeliharaan berkala sistem pemadam kebakaran aktif dan pasif di RS																		
44.	Identifikasi area berisiko kebakaran	Semua area berisiko kebakaran														Seluruh unit	Komite K3RS	PT. DPM	
45.	Simulasi kebakaran minimal setahun sekali	Semua Staf – K3RS														Seluruh unit	Komite K3RS	PT. DPM	
46.	Monitoring pelaksanaan monitoring Kawasan Tanpa Merokok (KTR).	Semua Area RS - Security														Seluruh area RS	Security	PT. DPM	
47..	Identifikasi penilaian kebutuhan peralatan medis beserta uji fungsi	Seluruh peralatan medis -ATEM														Seluruh unit yang memiliki alkes	ATEM	PT. DPM	
48	Inventarisasi peralatan medis baik yang KSO ataupun yang Non-KSO	Seluruh peralatan medis -ATEM														Seluruh unit yang memiliki alkes	ATEM	PT. DPM	
49.	Melakukan uji fungsi pada peralatan medis baru	ATEM dan user peralatan medis baru														Seluruh unit yang memiliki alkes	ATEM	PT. DPM	

NO	Kegiatan	Sasaran	Bulan												Tempat	PIC	Sumber Dana	Ket	
			12/25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
50.	Pemeriksaan peralatan medis	Seluruh peralatan medis -ATEM														Seluruh unit yang memiliki alkes	ATEM	PT. DPM	
51.	Pengujian peralatan medis	Seluruh peralatan medis -ATEM														Seluruh unit yang memiliki alkes	ATEM	PT. DPM	
52.	Pemeliharaan preventif dan kalibrasi peralatan medis	Seluruh peralatan medis -ATEM														Seluruh unit yang memiliki alkes	ATEM	PT. DPM	
53.	Pemantauan, pemberitahuan kerusakan (malfungsi) dan penarikan (<i>recall</i>) peralatan medis yang membahayakan pasien	Semua alat medis yang recall -ATEM														Seluruh unit yang memiliki alkes	ATEM	PT. DPM	
54.	Memastikan ketersediaan air dan listrik 24 jam setiap hari dan dalam waktu 7 hari dalam seminggu	Semua area Rumah Sakit - IPSRS														Seluruh unit	IPSRS	PT. DPM	
55.	Pembuatan daftar inventaris sistem utilitas dan peta distribusinya	Semua sistem utilitas di RS - IPSRS														Seluruh unit	IPSRS	PT. DPM	

NO	Kegiatan	Sasaran	Bulan												Tempat	PIC	Sumber Dana	Ket
			12/25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
56.	Melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, serta perbaikan semua komponen utilitas yang ada di daftar inventaris dan komponen kritisnya dan sumber alternatif	Semua sistem utilitas di RS – IPSRS														Seluruh unit	IPSRS	PT. DPM
57.	Membuat jadwal pemeriksaan, uji fungsi dan pemeliharaan semua sistem utilitas berdasar atas kriteria seperti rekomendasi dari pabrik, tingkat risiko, dan pengalaman rumah sakit	Semua sistem utilitas di RS – IPSRS														Seluruh unit	IPSRS	PT. DPM
58.	Pelabelan tuas-tuas kontrol pada sistem utilitas	Semua label tuas kontrol – IPSRS														Seluruh unit	IPSRS	PT. DPM
59.	Mengidentifikasi peralatan, sistem, serta area yang memiliki risiko paling tinggi terhadap pasien dan staf	Semua area di RS														Seluruh unit	IPSRS	PT. DPM

NO	Kegiatan	Sasaran	Bulan												Tempat	PIC	Sumber Dana	Ket
			12/25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
60.	Pengujian sumber cadangan atau alternatif air bersih dan listrik minimal 6 bulan sekali dan mendokumentasikan	Semua sumber cadangan dan alternatif air bersih dan listrik														Seluruh unit	IPSRS	PT. DPM
61.	Monitoring dan pemeriksaan mutu air bersih	Air bersih														Unit terkait	Kesling/ PPI	PT. DPM
62.	Monitoring dan pemeriksaan mutu air limbah	Air Limbah														IPAL	Kesling/ PPI	PT. DPM
64.	Pembuatan denah update terkait seluruh infrastruktur di Rumah Sakit	Semua Area Rumah Sakit														Seluruh area RS	Umum	PT. DPM
65.	Penambahan tangki bahan bakar genset	Genset Rumah Sakit														Genset	IPSRS	PT. DPM
66.	Pembuatan digram wiring listrik.	Semua Area Rumah Sakit														Seluruh area RS	IPSRS	PT. DPM
67.	Pembuatan regulasi penanggulangan bencana	Semua Staf RS														IGD	Kepala IGD	PT. DPM
68.	Pembuatan <i>Hazard Vulnerability Analylis (HVA)</i>	Semua risiko bencana yang bisa terjadi di RS														-	K3RS	PT. DPM

NO	Kegiatan	Sasaran	Bulan												Tempat	PIC	Sumber Dana	Ket
			12/25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
69.	Pembuatan tim penanggulangan keadaan darurat	Tim penanggulangan bencana															K3RS	PT. DPM
70.	Simulasi penanggulangan keadaan darurat	Semua Staf Rumah Sakit														Semua unit	K3RS	PT. DPM
71.	Penyediaan area dekontaminasi pada Instalasi Gawat Darurat (IGD)	IGD														IGD	Manajemen RS	PT. DPM
72.	Melaksanakan PCRA ketika proses renovasi, kontruksi dan demolisi	Ketika ada konstruksi. renovasi atau demolisi														Seluruh unit	Komite K3RS	PT. DPM
73.	Pelatihan MFK terkait keselamatan	Seluruh Staf RS														Seluruh unit	Diklat	PT. DPM
74.	Pelatihan MFK terkait keamanan	Seluruh Staf RS														Seluruh unit	Diklat	PT. DPM
75.	Pelatihan MFK terkait pengelolaan B3 dan limbahnya	Seluruh Staf RS														Seluruh unit	Diklat	PT. DPM
76.	Pelatihan MFK terkait proteksi kebakaran	Seluruh Staf RS														Seluruh unit	Diklat	PT. DPM
77.	Pelatihan MFK terkait peralatan medis	Seluruh Staf RS														Seluruh unit	Diklat	PT. DPM
78.	Pelatihan MFK terkait sistem utilitas	Seluruh Staf RS														Seluruh unit	Diklat	PT. DPM
79.	Pelatihan MFK terkait penanganan bencana	Seluruh Staf RS														Seluruh unit	Diklat	PT. DPM

NO	Kegiatan	Sasaran	Bulan												Tempat	PIC	Sumber Dana	Ket	
			12/25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
80.	Pelatihan MFK kepada vendor, pekerja kontrak, relawan, pelajar, peserta didik, peserta pelatihan dan lainnya (jika ada).	Vendor, pekerja kontrak, relawan, pelajar, peserta didik, peserta pelatihan dan lainnya (jika ada).														Seluruh unit	Diklat	PT. DPM	
81.	Pelatihan eksternal terkait Ahli K3 Listrik	Teknisi Listrik														Kondisional	Diklat/ Tim MFK	PT. DPM	
82.	Pelatihan eksternal terkait K3 Rumah Sakit	K3														Kondisional	Diklat/ Tim MFK	PT. DPM	
83.	Pelatihan eksternal terkait Safety Riding dan Driving	Tim MFK														Kondisional	Diklat/ Tim MFK	PT. DPM	

3.5 Kebutuhan Anggaran

Semua anggaran akan dibiayai dari Rencana Bisnis Anggaran yang telah disetujui oleh PT. Disa Prima Medika

Tabel Perhitungan biaya berdasarkan pemakaian rata -rata perbulan adalah sebagai berikut :

NO.	KEBUTUHAN	RATA ² /BULAN	KEBUTUHAN 1 TAHUN	HARGA SATUAN (RP)	TOTAL (RP)
1.	Pengarsipan dan administrasi terkait regulasi di Rumah Sakit		1x	100.000	100.000
2.	Pengarsipan dan administrasi terkait perizinan di Rumah Sakit		1x	100.000	100.000
3.	Manajemen risiko fasilitas, keselamatan dan keamana dan berkaitan dengan MFK		1x	10.000.000	10.000.000
4.	Penyediaan handrail di kamar mandi pasien		Sesuai kebutuhan (estimasi ada kerusakan sebanyak 40 buah selama Januari 2025- Desember 2025) stok 5 pcs/bulan = 60 pcs/ tahun	135.000	8.100.000
5.	Penyediaan side rail di bed pasien berfungsi dengan baik		10 pcs (5 pengganti kerusakan dan 5 untuk stok pengganti kerusakan)	1.500.000	15.000.000
6.	Penyediaan APD di rumah sakit		Sesuai Proker PPI	611.518.400	611.518.400
7	Mapping area berisiko keselamatan		Pembiayaan vendor penggambaran denah update RS	Rp 50.000.000	50.000.000
8.	Melakukan supervisi terkait sarana dan prasarana (ronde fasilitas)		12x	Rp 50.000,-	Biaya ATK form supervisi sarana dan prasarana
9.	Medical Check Up (MCU) secara berkala pada seluruh karyawan – Pemeriksaan dokter umum		Total Staf (Pemeriksaan HbsAg dan Anti HIV) = 398 orang Total Staf Unit Khusus = 81 orang	Rp 58.972.000,-	Rp 58.972.000,-



NO.	KEBUTUHAN	RATA ² / BULA N	KEBUTUHAN 1 TAHUN	HARGA SATUAN (RP)	TOTAL (RP)
			Harga Thorax = Rp. 104.000,-/ pax x 81 = Rp. 8.424.000,- Harga HbsAg = Rp. 55.000,-/ pax x 398 = Rp. 21.890.000,- Harga Anti HIV = Rp. 72.000/pax x 398 = Rp. 28.656.000,-		
10.	<i>Rectal Swab</i> pada penjamah makanan		Total Staf Dapur (Rectal Swab) = 10 orang Harga Rectal Swab = Rp. 375.000,-/pax x 10 = Rp 3.750.000,- / 2 semester	Rp. 375.000,- @ orang	Rp. 7.500.000,-
11.	Senam Kesehatan Jumat Berkah		54x	Rp. 100.000,-	Rp. 5.400.000,-
12.	Futsal bagi Karyawan Laki-Laki		12x	Rp. 800.000,-	Rp 9.600.000
13.	Badminton bagi Staf		12x	Rp. 840.000,-	Rp. 10.080.000,-
14.	Hipnoterapi pada Staf		2x	Rp. 100.000,-	Rp 200.000
15.	Pemberian vitamin bagi staf		454	Rp. 30.000,-	Rp 13.620.000
16.	Pemberian makanan tambahan bagi seluruh staf setiap Hari Jumat		54x	-	Anggaran Gizi dan Dapur
17.	Pemberian makanan tambahan bagi staf Radiologi		Setiap hari	-	Anggaran Gizi dan Dapur
18.	Pemberian fasilitas BPJS TK bagi staf		12x	-	Anggaran PT DPM
19.	Pemberian vaksin hepatitis bagi staf yang berada di area risiko tinggi misalnya IKO, ICU, IGD, Laboratorium, Maternitas, Perinatologi, IRJA, IRNA, Petugas B3, CSSD dan Laundry dan Petugas <i>Cleaning Service</i> (CS).		Harga vaksin per dosis = Rp 220.000, dan dibutuhkan maksimal 3 dosis/orang , ditambah pemeriksaan Anti HbsAg Elisa = Rp 300.000 , estimasi per orang	Rp. 1.000.000,-	Rp. 270.000.000,-



NO.	KEBUTUHAN	RATA ² / BULA N	KEBUTUHAN 1 TAHUN	HARGA SATUAN (RP)	TOTAL (RP)
			dibutuhkan Rp 1.000.000		
20.	Pemberian identitas (<i>badge</i> nama sementara atau tetap) pada pasien, staf, pekerja kontrak, tenant (penyewa lahan), keluarga (penunggu pasien) atau pengunjung (pengunjung diluar jam besuk dan tamu RS		Biaya penggantian cetak tanda pengenal pengunjung dll	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-
21.	Pemeriksaan dan pemantauan fasilitas dan lingkungan melalui CCTV selama 24 jam oleh petugas security dalam menghindari risiko keamanan		Untuk biaya ATK form patroli dan range jika ada kerusakan CCTV atau penambahan CCTV baru	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
22.	Pemeriksaan dan pemantauan fasilitas dan lingkungan melalui patroli keamanan oleh petugas security.		Setiap hari	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
23.	Pengelolaan risiko kekerasan, kejahatan dan acaman dilingkungan Rumah Sakit		Penambahan informasi terkait kekerasan di area RS - PKRS	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
24.	Pembuatan Panduan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbahnya secara <i>update</i>		1x	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
25.	Inventarisasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbahnya yang meliputi jenis, jumlah, simbol dan lokasi		2x	Rp. 75.000,-	Rp. 150.000,-
26.	Penanganan, penyimpanan dan penggunaan B3 dan limbahnya		Estimasi Limbah infeksius, tajam /bulan (dilihat dari perhitungan limbah rata-rata Januari 2025 – Desember 2025, ada sekitar 1.818 kg/ bulan limbah yang diambil kg/bulan dengan harga Rp 8500/kg untuk tahun 2025 dan estimasi kebutuhan	Rp.209.436.000, -	Rp.209.436.000, -



NO.	KEBUTUHAN	RATA ² / BULA N	KEBUTUHAN 1 TAHUN	HARGA SATUAN (RP)	TOTAL (RP)
			kantong Limbah = 1.818 kg x Rp. 8.500 = Rp. 15.453.000/ bulan = Rp. 185.436.000/ tahun Limbah Domestik = Rp 2,000,000/ bulan = Rp 24,000,000/ tahun		
27.	Pelatihan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan prosedur bila terjadi tumpahan paparan/pajanan (<i>spill kit</i> dan <i>eye washer</i>)		Penggunaan Spill Kit (Anggaran PPI) dan exlude anggaran SDM terkait pelatihan	-	Rp 7.514.000,-
28.	Pelatihan yang dilakukan oleh staf yang menangani Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)		Semua staf	-	(Anggaran SDM)
29.	Pemberian label/rambu-rambu yang tepat pada B3 dan limbahnya		Setiap hari	Rp. 50.000,- / hari	Rp. 18.250.000,-
30.	Pelaporan dan investigasi dari tumpahan, eksposur (terpapar) dan insiden lainnya, dimana termasuk pemenuhan spill kit		Anggaran PPI - dengan google form	Rp 0	Rp 0
31.	Pengarsipan dokumentasi, termasuk izin, lisensi, atau persyaratan peraturan lainnya		-	-	Biaya ATK termasuk operasional RS
32.	Melampirkan Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) atau <i>Material Safety Data Sheet (MSDS)</i> ketika pengadaan/pembelian B3 dan pemasok (supplier).		Insidentil ketika terdapat pengadaan	-	Biaya ATK termasuk operasional RS
33.	Melakukan penyimpanan limbah di TPS B3 sesuai aturan yang berlaku		Harga penggantian sulo jika terjadi kerusakan @Rp 900.000,- diibaratkan ada	Harga penggantian sulo jika terjadi kerusakan @Rp 900.000,-	Rp. 10.800.000,-



NO.	KEBUTUHAN	RATA ² / BULA N	KEBUTUHAN 1 TAHUN	HARGA SATUAN (RP)	TOTAL (RP)
			penggantian 12x dalam setahun atau sebulan sekali		
34.	Pengukuran pH dan debit air limbah		-	Penggantian alat baru, ketika terjadi kerusakan	Rp. 300.000,-
35.	Melakukan pengolahan limbah B3 dengan pihak ketiga sesuai Mou yang berlaku		Sesuai dengan biaya penanganan limbah B3 dan penyimpanan limbah B3	-	Rp 0
36.	Penyimpanan dan penanganan bahan bahan mudah terbakar secara aman termasuk gas-gas medis yang mudah terbakar dengan pemasangan rantai dan pengaman lainnya		Setiap hari	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,- (Estimasi pelengkapan rantai pengaman di gas medis)
37.	Pengendalian potensi bahaya dan risiko kebakaran yang terkait dengan konstruksi apapun di atau yang berdekatan dengan bangunan yang ditempati pasien		Pembangunan tembok atau mengurasi partisi di RS	Rp. 25.000.000,-	Rp 25.000.000,- (Melengkapi papan evakuasi yang terdapat fosfor)
38.	Penyediaan rambu dan jalan keluar (evakuasi) yang aman		Estimasi penggantian rambu evakuasi atau penambahan jalur evakuasi baru	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
39.	Penyediaan dan pemeliharaan sistem peringatan dini secara pasif meliputi detector asap, detector panas, alarm kebakaran dan lain-lain		Pemeliharaan sistem pemadam api pasif dari vendor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
40.	Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pemadam api aktif meliputi APAR, hydrant, sistem sprinkler dan lain-lain		Pemeliharaan sistem pemadam api aktif dari vendor	Rp. 25.000.000,-	Rp 25.000.000,-
41.	Pembuatan sistem pemisahan (pengisolasian) dan kompartemenisasi		1x	Rp. 25.000.000,-	Pembuatan ruangan pengisolasi asap atau penambahan



NO.	KEBUTUHAN	RATA ² / BULA N	KEBUTUHAN 1 TAHUN	HARGA SATUAN (RP)	TOTAL (RP)
	pengendalian api dan asap				pintu tahan api dengan ketahanan api minimal 2 jam
42.	Inventarisasi, pemeriksaan berkala, uji coba dan pemeliharaan berkala sistem pemadam kebakaran aktif dan pasif di RS		Pemeriksaan dari damkar	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
43.	Identifikasi area berisiko kebakaran		Biaya ATK	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
44.	Simulasi kebakaran minimal setahun sekali		Biaya penggantian APAR yang digunakan untuk simulasi, penggunaan vendor	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
45.	Monitoring pelaksanaan monitoring Kawasan Tanpa Merokok (KTR).		Biaya ATK	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
46.	Identifikasi penilaian kebutuhan peralatan medis beserta uji fungsi		-	-	Biaya ATK termasuk operasional RS
47.	Inventarisasi peralatan medis baik yang KSO ataupun yang Non-KSO		-	-	Biaya ATK termasuk operasional RS
48.	Melakukan uji fungsi pada peralatan medis baru		-	-	Biaya ATK termasuk operasional RS
49.	Pemeriksaan peralatan medis		-	-	Biaya ATK termasuk operasional RS
50..	Pengujian peralatan medis		-	-	Biaya ATK termasuk operasional RS
51.	Pemeliharaan preventif dan kalibrasi peralatan medis		-	Rp. 500.000.000,-	Rp. 500.000.000,-
52.	Pemantauan, pemberitahuan kerusakan (malfungsi) dan penarikan (<i>recall</i>) peralatan medis yang membahayakan pasien		Setiap hari	Rp. 300.000.000,-	Rp. 300.000.000,-
53.	Memastikan ketersediaan air dan listrik 24 jam setiap hari dan dalam waktu 7 hari dalam seminggu		Setiap hari	Estimasi tarif listrik per bulan Rp.100.000.000,- / bulan dan pajak air sekitar Rp.	Rp 132.000.000,-



NO.	KEBUTUHAN	RATA ² / BULA N	KEBUTUHAN 1 TAHUN	HARGA SATUAN (RP)	TOTAL (RP)
				1.000.000,-/ bulan	
54.	Pembuatan daftar inventaris sistem utilitas dan peta distribusinya		Setiap hari	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
55.	Melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, serta perbaikan semua komponen utilitas yang ada di daftar inventaris dan komponen kritisnya dan sumber alternatif		Setiap hari	Rp. 500.000.000,-	Rp. 500.000.000,-
56.	Membuat jadwal pemeriksaan, uji fungsi dan pemeliharaan semua sistem utilitas berdasar atas kriteria seperti rekomendasi dari pabrik, tingkat risiko, dan pengalaman rumah sakit		-	-	Biaya ATK operasional RS
57.	Pelabelan tuas-tuas kontrol pada sistem utilitas		Setiap hari	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
58.	Mengidentifikasi peralatan, sistem, serta area yang memiliki risiko paling tinggi terhadap pasien dan staf		-	-	Biaya ATK operasional RS
59.	Pengujian sumber cadangan atau alternatif air bersih dan listrik minimal 6 bulan sekali dan mendokumentasikan		setiap pengujian genset memerlukan 20 liter solar/minggu = 20 x 54 x Rp 7000 = Rp 7.560.000, estimasi untuk pengujian air bersih satu tangki Rp 900,000 / 6 bulan sekali = Rp 1,800,000	Rp. 9.360.000,-	Rp 9.360.000,-
60.	Monitoring dan pemeriksaan mutu air bersih		Air minum per bulan Rp. 120,000,-/ bulan x Rp 12 = Rp 1,440,000,- Air bersih kimia 6 bulan sekali = Rp	Estimasi Rp. 3.897.000,- /bulan	Rp. 46.764.000,-



NO.	KEBUTUHAN	RATA ² / BULA N	KEBUTUHAN 1 TAHUN	HARGA SATUAN (RP)	TOTAL (RP)
			187,000 x 2 = Rp. 3.740.00,- Fisika Air 6 bulan sekali Rp 132.000 x 2 = Rp. 264,000,- Air bersih 10 titik / bulan = Rp. 112,000,- x 10 x 12 = Rp .13,440,000,- Kimia ir bersih 6 bulan sekali 10 titik = Rp. 187.000,- x 2 = Rp. 3.740.000,- Fisika Air bersih 10 titik, 6 bulan sekali Harga per titik Rp 132,000 x 2 x 10 = Rp 2.640.000,- Uji udara ambient bulan sekali Rp. 5.000.000,- x 2 = Rp 10.000.000,- Uji kebisingan+penc ahayaaaan 6 bulan sekali 1 titik Rp. 5.000.000,- = Rp. 10.000.000,- Uji emisi 6 bulan sekali, sekali Rp. 750,000,- x 2 = Rp 1.500.000,-		
61.	Monitoring dan pemeriksaan mutu air limbah		12x	Rp. 4.500.000,-	Rp. 54.000.000,-
62.	Monitoring pemeriksaan mutu air yang digunakan untuk dialisis ginjal setiap bulan untuk menilai pertumbuhan bakteri dan endotoksin		12x	Rp. 2.250.000,-	Rp. 27.000.000,-
63.	Pembuatan denah update terkait seluruh		1x	Rp 200.000.000	Rp.200.000.000



NO.	KEBUTUHAN	RATA ² / BULA N	KEBUTUHAN 1 TAHUN	HARGA SATUAN (RP)	TOTAL (RP)
	infrastruktur di Rumah Sakit				(Estimasi pembiayaan vendor)
64.	Penambahan tangki bahan bakar genset		1x	Rp. 75.000.000,-	Rp. 75.000.000,- (Pengajuan vendor)
65.	Pembuatan digram wiring listrik.		1x	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
67.	Pembuatan regulasi penanggulangan bencana		-	-	Anggaran ATK-operasional
68.	Pembuatan <i>Hazard Vulnerability Analylis (HVA)</i>		-	-	Anggaran ATK-operasional
69.	Pembuatan tim penanggulangan keadaan darurat		-	-	Anggaran ATK-operasional
70.	Simulasi penanggulangan keadaan darurat		1x	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
71..	Penyediaan area dekontaminasi pada Instalasi Gawat Darurat (IGD)		1x	Mengikuti pengajuan APD	Anggaran PPI
72	Melaksanakan PCRA ketika proses renovasi, kontruksi dan demolisi		Insidentil	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,- Dengan pemberian APD konstruksi, barrier pembatas, penanda atau informasi adanya renovasi/demolisi atau konstruksi dan alat pendukung K3 lainnya
73.	Pelatihan MFK terkait keselamatan		1x	-	Anggaran SDM-Diklat
74.	Pelatihan MFK terkait keamanan		1x	-	Anggaran SDM-Diklat
75.	Pelatihan MFK terkait pengelolaan B3 dan limbahnya		1x	-	Anggaran SDM-Diklat
76.	Pelatihan MFK terkait proteksi kebakaran		1x	-	Anggaran SDM-Diklat
77.	Pelatihan MFK terkait peralatan medis		1x	-	Anggaran SDM-Diklat
78.	Pelatihan MFK terkait sistem utilitas		1x	-	Anggaran SDM-Diklat
79.	Pelatihan MFK terkait penanganan bencana		1x	-	Anggaran SDM-Diklat



NO.	KEBUTUHAN	RATA ² / BULA N	KEBUTUHAN 1 TAHUN	HARGA SATUAN (RP)	TOTAL (RP)
80.	Pelatihan MFK kepada vendor, pekerja kontrak, relawan, pelajar, peserta didik, peserta pelatihan dan lainnya (jika ada).		1x	-	Anggaran SDM-Diklat
81.	Pelatihan eksternal terkait Ahli K3 Listrik		1x	-	Anggaran SDM-Diklat
82.	Pelatihan eksternal terkait K3 Rumah Sakit		1x	-	Anggaran SDM-Diklat
83.	Pelatihan eksternal terkait <i>Safety Driving</i> dan <i>Riding</i>		1x	-	Anggaran SDM-Diklat
TOTAL					Rp 4.516.914.400



BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

4.1 Monitoring Kegiatan

Monitoring kegiatan dilakukan berdasarkan hasil supervisi, hasil kinerja maupun temuan ataupun permasalahan yang terjadi di unit/komite.

4.2 Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan data 3 bulan terakhir, misalnya, evaluasi pada Bulan April 2026, Juli 2026, Oktober 2026 dan Desember 2026 untuk membandingkan hasil kinerja dari hasil supervisi sebelumnya, yang akan dibahas dalam setiap rapat unit maupun rapat antar unit dan kemudian akan dilakukan rencana tindaklanjut yang akan dimasukkan kedalam laporan.



BAB V
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pencatatan kegiatan dilakukan secara harian dan akan dilaksanakan berdasarkan rencana kegiatan. Laporan dibuat berdasarkan hasil kinerja dari program yang telah dilakukan. Laporan ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit. Tembusan Laporan diserahkan kepada PT. Disa Prima Medika. Laporan dapat berupa :

1. Laporan bulanan;
2. Laporan triwulan;
3. Laporan semester;
4. Laporan tahunan;
5. Laporan insidental .



BAB VI
PENUTUP

Demikian program kerja unit Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (Komite K3RS) yang disusun dan disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di RS Prima Husada Malang tahun 2026. Segala dukungan dan kerjasama yang diberikan dapat menunjang terlaksananya program kerja yang sudah disusun.

Mengetahui

PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestiantini, M.Kes

Malang, 31 Desember 2025

Ketua Komite K3RS,

Faisal Aminuddin Ilham, S.KM

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 549/I-PDM/DIR/VI/2025**

**TENTANG
RISK REGISTER RUMAH SAKIT**

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan fasilitas yang aman, berfungsi, dan suportif bagi pasien, keluarga, staf, dan pengunjung;
- b. bahwa untuk membantu pihak manajemen rumah sakit dalam mengurangi dan mengendalikan sumber bahaya dan risiko, menghindari kecelakaan dan cedera, serta memelihara kondisi yang aman;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit, diperlukan pengelolaan risiko yang terstruktur dan terdokumentasi;
- d. bahwa Risk Register merupakan salah satu instrumen dalam manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko di lingkungan Rumah Sakit;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d maka perlu penetapan Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Risk Register Kerja Rumah Sakit.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di Fasyankes;
5. Permenkes No. 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
6. Standar Akreditasi Rumah Sakit (STARKES) 2022 yang menekankan manajemen risiko.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Fasyankes;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
10. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;
11. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 263/DPM/I-KEP/DIR/I/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
TENTANG PENETAPAN RISK REGISTER RUMAH SAKIT**
- Kedua : Risk Register sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu digunakan sebagai pedoman dalam proses identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, dan pemantauan risiko di lingkungan Rumah Sakit Prima Husada Malang.



- Ketiga : Seluruh Kepala Unit/Instalasi wajib menyusun, melaksanakan, dan melakukan pembaruan Risk Register secara berkala serta melaporkan hasilnya kepada Direktur melalui Komite Mutu/Tim Manajemen Risiko.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 01 Juni 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah



SURAT KETERANGAN

NOMOR : 579/E-SKT/DIR/III/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Resti Lestiantini, M.Kes
Jabatan : PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada

Dengan ini menyatakan bahwa :

Rumah Sakit Prima Husada saat ini tidak memiliki **tenant atau pihak ketiga yang menyewa atau menjalankan usaha di lingkungan** Rumah Sakit.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 02 Januari 2026

Hormat kami,

PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestiantini, M.Kes



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN TAHUNAN
KECELAKAAN KERJA K3RS MFK
TAHUN 2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

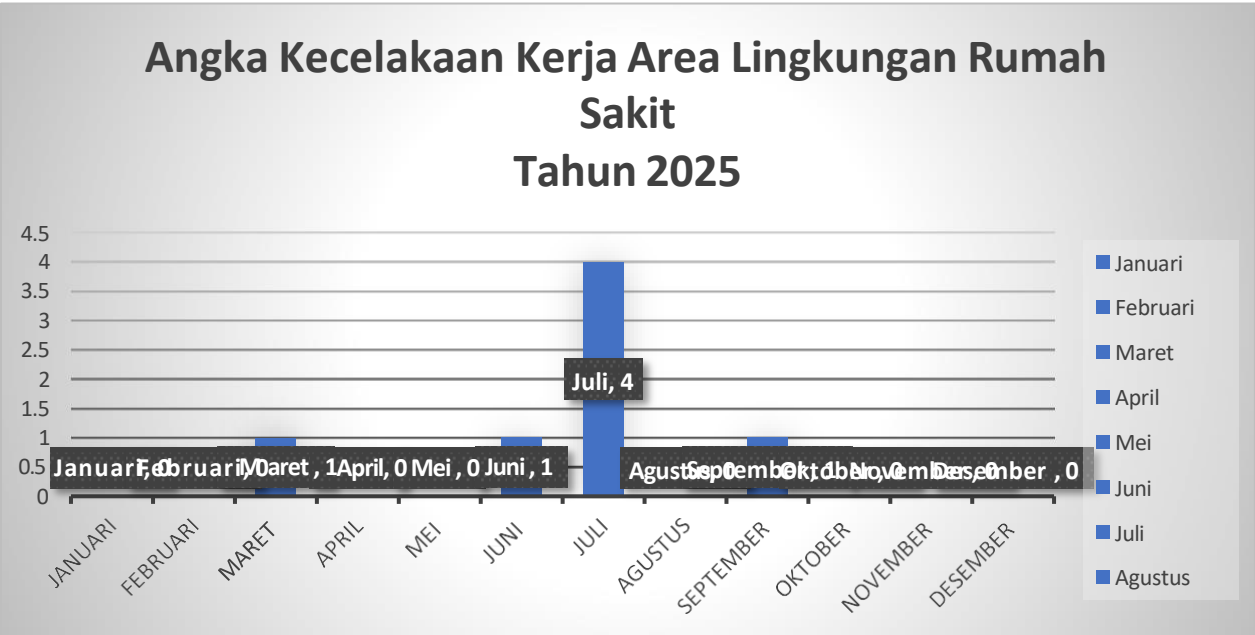
www.rs-primahusada.com



Tabel 1. Jumlah Angka Kecelakaan Kerja Tahun 2025

Bulan	Angka Kecelakaan Kerja	Keterangan
Januari	-	Tidak ada laporan kecelakaan kerja.
Februari	-	Tidak ada laporan kecelakaan kerja.
Maret	1	1 orang petugas dapur terkilir tangan kanan saat mengambil box makanan (cedera ringan), posisi pengambilan yang salah, tindakan penanganan dibawa ke IGD.
April	-	Tidak ada laporan kecelakaan kerja.
Mei	-	Tidak ada laporan kecelakaan kerja.
Juni	1	Tgl 26 Juni 2025, salah satu petugas dokter MCU terkena jarum (saat akan dibuang) luka pada jari.
Juli	4	Terjadi 4 kali kejadian kecelakaan kerja pada bulan Juli 1. Tanggal 18 Juli 2025, seorang petugas CS tertusuk jarum yang menembus lapisan safety box, safety box tidak tahan tembus. 2. Tanggal 20 Juli 2025, seorang petugas CS IGD membersihkan kloset kamar mandi di masjid dengan menggunakan cairan lime away. Cairan tersebut dimasukkan ke botol bekas, staf lupa jika botol bekas tersebut bekas bayclin, akhirnya menguao dan terhirup. 3. Tanggal 16 Juli 2025, 2 petugas IPSRS, saat melakukan pengecekan dan perbaikan tekanan dental unit 2, menggunakan air sabun, lalu tiba - tiba air sabun meledak dan mengenai mata
Agustus	-	Tidak ada laporan kecelakaan kerja.
September	1	1 orang petugas IGD tertusuk jarum saat memegang pasien (tidak tenang).
Oktober	0	Tidak ada laporan kecelakaan kerja.
November	0	Tidak ada laporan kecelakaan kerja.
Desember	0	Tidak ada laporan kecelakaan kerja.

Grafik 1. Angka Kecelakaan Kerja Tahun 2025



Keterangan :

Kecelakaan kerja terbanyak terjadi di bulan Juli sejumlah 4 kejadian.

Analisis :

- a) Januari 0 kecelakaan kerja.
- b) Februari 0 kecelakaan kerja.
- c) Maret 1 kecelakaan kerja.
- d) April 0 kecelakaan kerja.
- e) Mei 0 kecelakaan kerja.
- f) Juni 1 kecelakaan kerja.
- g) Juli 4 kecelakaan kerja.
- h) Agustus 0 kecelakaan kerja.
- i) September 1 kecelakaan kerja.
- j) Oktober 0 kecelakaan kerja.
- k) November 0 kecelakaan kerja.
- l) Desember 0 kecelakaan kerja.

Malang, 31 Desember 2025

Mengetahui

Ketua P2K3RS
RS Prima Husada Malang



(Faisal Aminuddin Ilham, S.KM)

PLT Direktur
RS Prima Husada Malang



(dr. Resti Lestiantini, M.Kes)



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN TAHUNAN
LAPORAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN
K3RS MFK
TAHUN 2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com



Tabel 1. Laporan Keamanan dan Keselamatan K3RS MFK Tahun 2025

BULAN	KEHILANGAN BARANG	BARANG BERPOTENSI HILANG	KEKERASAN	MEROKOK DI AREA RUMAH SAKIT
Januari	1 (satu) kejadian yaitu : telah ditemukan uang sejumlah 150 ribu oleh petugas pendaftaran mbk susan di area Gedung poli spesialis , diamankan di pos IGD.	4 (tiga) kejadian yaitu : 1. Telah ditemukan tas warna pulkadot di ruang tunggu farmasi diamankan di pos IGD telah diambil pemilik. 2. Laporan kehilangan barang pribadi berupa dompet oleh pengunjung di area masjid RSPH a/n IMRON telah diambil pemilik. 3. Telah ditemukan berkas a/n SALIM diamankan di pos IGD telah diambil pemilik. 4. Telah ditemukan hp pengunjung di area taman depan farmasi diamankan di pos IGD telah diambil pemilik.	-	Total 3 pengunjung yang merokok sudah di beri edukasi dan pengarahan terkait larangan area dilarang merokok.
Februari	-	5 (lima) kejadian yaitu : 1. Telah ditemukan kunci motor karyawan yang tertinggal di area poli , diamankan di pos poli telah diambil pemilik. 2. Telah ditemukan kunci motor karyawan yang tertinggal di area parkir belakang , diamankan di pos poli telah diambil pemilik. 3. Telah ditemukan kunci mobil yang tertinggal di ruang tunggu poli orthopedi ,	-	Total 5 pengunjung yang merokok sudah di beri edukasi dan pengarahan terkait larangan area dilarang merokok.



		diamankan di pos poli telah diambil pemilik. 4. Telah ditemukan kunci motor yang tertancap di motor karyawan parkir tingkat, diamankan di pos igd telah diambil pemilik. 5. Telah ditemukan helm di ruang tunggu poli lt 2 diamankan di pos igd telah diambil pemilik.		
Maret	-	14 (empat belas) kejadian yaitu : 1. Ditemukan kalung dan bandung dibawah kursi ruang tunggu IKO, diamankan di pos IGD telah diambil pemilik. 2. Ditemukan dompet tertinggal di area depan pendaftaran IGD, diamankan di pos IGD telah diambil pemilik. 3. Ditemukan kunci kontak kendaraan R2 oleh rekan cs telah diambil pemilik. 4. Ditemukan kontak motor milik pasien IGD rawat jalan, diamankan di pos IGD telah diambil pemilik. 5. Ditemukan kontak motor tertinggal di parkir karyawan lt 2 diamankan di pos poli telah diambil pemilik. 6. Ditemukan topi anak di kursi tunggu	-	Total 1 pengunjung yang merokok sudah di beri edukasi dan pengarahannya terkait larangan area dilarang merokok.



		pendaftaran poli central , diamankan di pendaftaran central telah diambil pemilik. 7. Ditemukan dompet keluarga pasien ditemukan di ruang tunggu farmasi ,diamankan di farmasi telah diambil pemilik. 8. Ditemukan dompet keluarga pasien ditemukan di ruang tunggu farmasi ,diamankan di farmasi telah diambil pemilik. 9. Ditemukan kontak motor depan lift poli lantai 1 telah diambil pemilik. 10. Ditemukan sandang keluarga pasien ditemukan di depan ruang tunggu IKO depan telah diambil pemilik. 11. Ditemukan kunci jatuh di area poli telah diambil pemilik 12. Ditemukan kunci motor pengunjung , diamankan di pos IGD telah diambil pemilik. 13. Ditemukan kunci di area poli central telah diambil pemilik. 14. Ditemukan berkas pasien atas nama daffasyah , diamankan di pos igd telah diambil pemilik.		
April	2 (dua) kejadian yaitu :	9 (sembilan) kejadian yaitu :		Total 32 pengunjung



	1. Telah terjadi kehilangan barang pribadi milik pasien (karyawan RSPH) berupa HP , posisi rawat inap di lantai 3A ruang cempaka , untuk penelusuran CCTV selasar IRNA nihil dikarenakan cctv dalam kondisi off & error (Koordinasi dengan team IT perihal perbaikan dan pemantauan CCTV , untuk CCTV sudah diperbaiki on dan pantauan normal). 2. Telah ditemukan uang dilantai 1 disekitar IKO sampai lift Gedung C,untuk uang diamankan di lantai 3C.	1. Telah ditemukan sim milik pengunjung di area cso ,diamankan di CSO telah diambil pemilik. 2. Telah ditemukan berkas pasien tertinggal dibawah lantai depan PIPP diamankan di pos IGD telah diambil pemilik. 3. Telah ditemukan kunci beat putih diparkiran karyawan diamankan di CSO telah diambil pemilik. 4. Telah ditemukan tas milik pasien tertinggal diarea poli pendaftaran , diamankan di pendaftaran central telah diambil pemilik. 5. Telah ditemukan dompet milik pasien tertinggal di area poli pendaftaran diamankan di pos poli telah diambil pemilik. 6. Telah ditemukan dompet milik pasien tertinggal di area poli pendaftaran diamankan di pos poli telah diambil pemilik. 7. Telah ditemukan kartu bpjs pasien diamankan di admisi 6 pendaftaran central telah diambil pemilik. 8. Telah ditemukan kunci motor karyawan di parkiran karyawan diamankan di		yang merokok sudah di beri edukasi dan pengarahannya terkait larangan area dilarang merokok.
--	--	---	--	--



		pos igd telah diambil pemilik. 9. Ditemukan berkas dan obat beserta kartu identitas pasien di kamar mandi KR2 blok C sementara diamankan di pos IGD telah diambil pemilik.		
Mei	-	7 (tujuh) kejadian yaitu : 1. Etol karyawan tertinggal saat doa pagi , diamankan di ruang cssd telah diambil pemilik. 2. Kunci motor karyawan tertinggal di area parkir karyawan di amankan di pos IGD telah diambil pemilik. 3. Kunci motor karyawan tertinggal di area parkir karyawan di amankan di pos IGD telah diambil pemilik. 4. Telah ditemukan STNK kendaraan bermotor di depan pos DPM ,diamankan di pos IGD telah diambil pemilik. 5. Kunci motor karyawan tertinggal di area parkir karyawan di amankan di pos IGD telah diambil pemilik. 6. Telah ditemukan berkas foto rontgen milik pasien di amankan di CSO telah diambil pemilik. 7. Ditemukan tas milik pasien tertinggal di	-	Total 43 pengunjung yang merokok sudah di beri edukasi dan pengarahan terkait larangan area dilarang merokok.



		ruang tunggu farmasi ,barang diamankan di farmasi telah diambil pemilik.		
Juni	1 (satu) kejadian yaitu : Ditemukan STNK milik pengunjung diamankan di pos IGD.	12 (dua belas) kejadian yaitu : 1. Telah ditemukan kartu bpjs milik pasien di CSO telah diambil pemilik. 2. Ditemukan kunci motor karyawan tertancap di motor telah diambil pemilik. 3. HP milik pengunjung hilang di area ruang tunggu farmasi yang tidak terpantau kamera (Berkoordinasi dengan team IT perihal pemasangan CCTV di area ruang tunggu farmasi). 4. Telah terjadi kehilangan uang milik karyawan di loker depo farmasi telah dilakukan penelusuran nihil dan tidak terpantau cctv (Berkoordinasi dengan team IT perihal pemasangan CCTV di area ruang tunggu farmasi). 5. Ditemukan kunci motor karyawan tertancap di motor , diamankan di pos igd telah diambil pemilik. 6. Ditemukan topi anak di pendaftaran central , diamankan dilaci pendaftaran central telah diambil pemilik.	-	Total 26 pengunjung yang merokok sudah di beri edukasi dan pengarahannya terkait larangan area dilarang merokok.



		7. Ditemukan kunci motor karyawan tertancap di motor, diamankan di pos IGD telah diambil pemilik. 8. Telah ditemukan hp dan hasil lab milik pasien di poli IPD telah diambil pemilik. 9. Telah di temukan identitas pasien berupa KTP di poli jantung telah diambil pemilik. 10. Telah di temukan identitas pasien berupa kk di warung telah diambil pemilik. 11. Telah ditemukan HP milik pengunjung di depan kursi ruang tunggu iko , diamankan di laci cso telah diambil pemilik. 12. Telah di temukan tablet hp milik pengunjung di poli anak telah diambil pemilik.		
Juli	1 (satu) kejadian yaitu : Ditemukan cincin perhiasan milik pengunjung, diamankan di ruang security	7 (tujuh) kejadian yaitu : 1. Ditemukan HP milik pengunjung di depan ruang tunggu iko diamankan di pos IGD telah diambil pemilik. 2. Kunci motor milik karyawan tertinggal di parkir an kr 2 karyawan telah diambil pemilik. 3. Kunci motor milik karyawan tertinggal di parkir an motor 2 karyawan telah	-	Total 29 pengunjung yang merokok sudah di beri edukasi dan pengarahan terkait larangan area dilarang merokok.



		diambil pemilik. 4. Kunci mobil milik pengunjung tertinggal di parkir motor 4 pengunjung telah diambil pemilik. 5. Ditemukan hp milik pengunjung di area poli diamankan di pos IGD telah diambil pemilik. 6. Kunci motor milik karyawan tertinggal di parkir motor 2 karyawan telah diambil pemilik. 7. Kunci motor milik karyawan tertinggal di parkir kr 2 karyawan telah diambil pemilik.		
Agustus	1 (satu) kejadian yaitu : Telah ditemukan selendang bayi di area Gedung poli spesialis (diamankan di belakang CSO ruang panel kresek putih).	7 (tujuh) kejadian yaitu : 1. Kunci motor menancap milik karyawan di sepeda motor diamankan di pos IGD telah diambil pemilik. 2. Kunci motor milik pengunjung menancap di sepeda motor diamankan di pos igd telah diambil pemilik. 3. Kunci motor menancap milik karyawan di sepeda motor diamankan di pos IGD telah diambil pemilik. 4. Kunci motor menancap milik karyawan di sepeda motor diamankan di pos igd telah diambil pemilik. 5. Telah ditemukan sejumlah uang	-	Total 20 pengunjung yang merokok sudah di beri edukasi dan pengarahan terkait larangan area dilarang merokok



		di area depan radiologi diamankan di pos igd telah diambil pemilik. 6. Kunci motor menancap milik karyawan di sepeda motor diamankan di pos IGD telah diambil pemilik. 7. Kunci motor menancap milik karyawan di sepeda motor diamankan di pos IGD telah diambil pemilik.		
September	-	5 (lima) kejadian yaitu : 1. Ditemukan kunci mobil diarea masjid di amankan di pos IGD telah diambil pemilik. 2. Ditemukan kunci motor tertinggal di parkir an karyawan diamankan di pos igd telah diambil pemilik. 3. Ditemukan kunci motor tertinggal di parkir an karyawan diamankan di pos IGD telah diambil pemilik. 4. Ditemukan HP milik pasien di ruang tunggu poli spesialis diamankan di pos IGD telah diambil pemilik. 5. Ditemukan HP milik pasien di ruang tunggu poli spesialis diamankan di pos IGD telah diambil pemilik.	-	Total 13 pengunjung yang merokok sudah di beri edukasi dan pengarah an terkait larangan area dilarang merokok
Oktober	-	7 (tujuh) kejadian yaitu : 1. Telah ditemukan kontak	-	Total 21 pengunjung yang merokok sudah di beri



		kendaraan milik pasien di area gedung poli spesialis, diamankan di pos IGD telah diambil pemilik. 2. Kontak motor milik karyawan tertancap di motor, diamankan di pos IGD telah diambil pemilik 3. Telah di temukan tas berisi hp milik pasien di depan toilet poli lantai 1 depan poli jiwa , diamankan di pos IGD telah diambil pemilik. 4. Kontak motor milik karyawan tertancap di motor , diamankan di pos IGD telah diambil pemilik. 5. Kontak motor milik keluarga pasien tertancap di motor , diamankan di pos IGD telah diambil pemilik. 6. Berkas karyawan ditemukan terjatuh di parkir an karyawan di amankan di pos IGD telah diambil pemilik. 7. Telah ditemukan kontak kendaraan milik pasien di area ruang tunggu farmasi, diamankan di pos IGD telah diambil pemilik.		edukasi dan pengarah an terkait larangan area dilarang merokok.
November	-	5 (lima) kejadian yaitu : 1. Telah ditemukan dompet milik pasien terjatuh di area gedung	-	Total 21 pengunjung yang merokok sudah di beri edukasi dan pengarah an

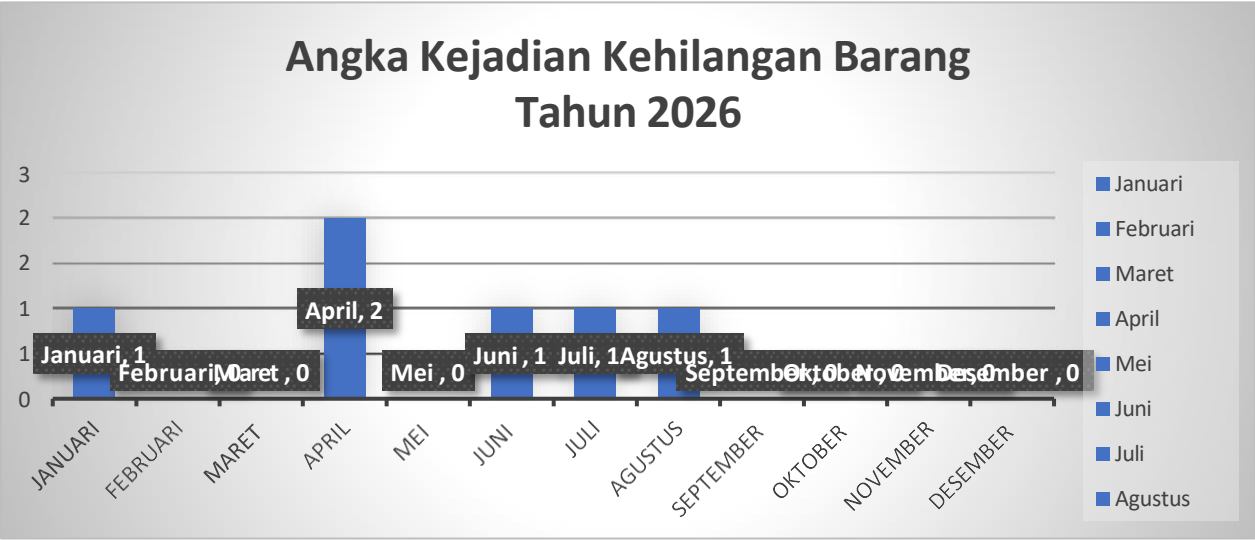


		poli spesialis diamankan di pos IGD telah diambil pemilik. 2. Kunci motor karyawan ditemukan tertancap di parkir kendaraan 2 karyawan di amankan di pos IGD telah diambil pemilik. 3. Telah ditemukan kunci kendaraan di area gedung poli spesialis diamankan di pos poli telah diambil pemilik. 4. Kunci motor karyawan ditemukan tertancap di parkir kendaraan 2 karyawan di amankan di pos IGD telah diambil pemilik. 5. Kunci motor karyawan ditemukan tertancap di parkir kendaraan 2 karyawan di amankan di pos IGD telah diambil pemilik.		terkait larangan area dilarang merokok.
Desember	-	9 (sembilan) kejadian yaitu : 1. Ditemukan kontak motor karyawan di area parkir motor diamankan di pos poli telah diambil pemilik. 2. Ditemukan barang pribadi milik pasien berupa topi bayi terjatuh di area gedung poli spesialis diamankan di pos poli telah diambil pemilik.	-	Total 14 pengunjung yang merokok sudah di beri edukasi dan pengarahannya terkait larangan area dilarang merokok.



		3. Ditemukan kontak motor karyawan di area parkir motor diamankan di pos IGD telah diambil pemilik. 4. Ditemukan kontak motor karyawan di area parkir motor belakang diamankan di pos IGD telah diambil pemilik. 5. Ditemukan jam tangan di area kamar poli lantai 2, diamankan di pos IGD telah diambil pemilik. 6. Ditemukan kontak motor karyawan di area parkir motor diamankan di pos poli telah diambil pemilik. 7. Ditemukan dompet terjatuh di depan parkir an igd , diamankan di pos IGD telah diambil pemilik. 8. Ditemukan kontak motor karyawan di area parkir motor diamankan di pos IGD telah diambil pemilik. Ditemukan tas tertinggal di area pendaftaran CSO , diamankan di pos poli telah diambil pemilik.		
--	--	---	--	--

Grafik 1. Angka Kejadian Kehilangan Barang Tahun 2025



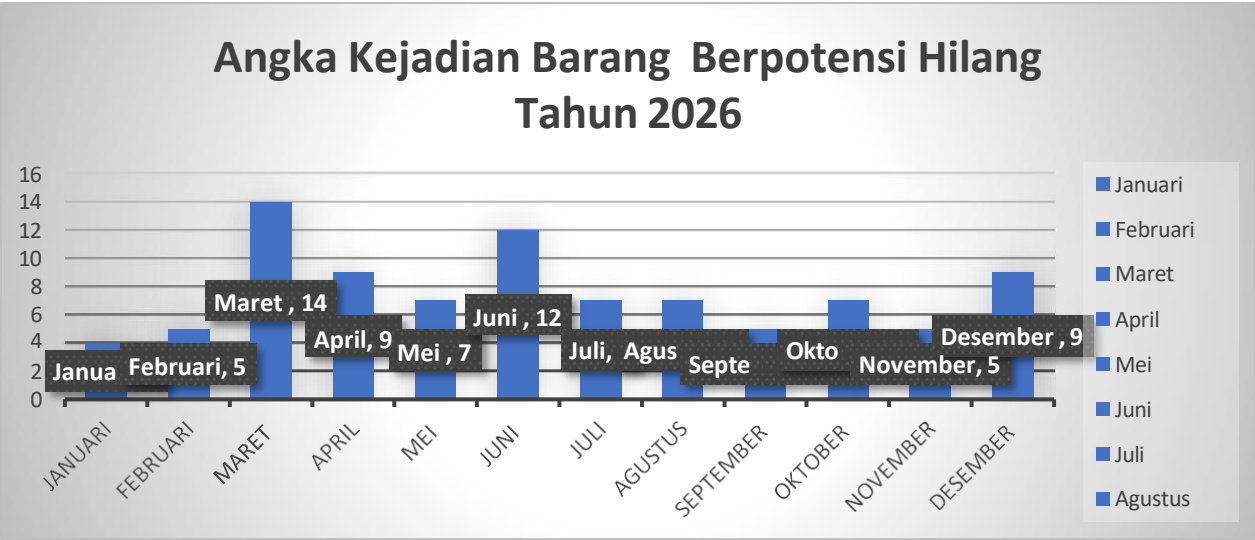
Keterangan :

Angka kejadian kehilangan barang terbanyak di bulan April sejumlah 2 kejadian.

Analisis :

- a) Januari 1 kejadian.
- b) Februari 0 kejadian.
- c) Maret 0 kejadian.
- d) April 2 kejadian.
- e) Mei 0 kejadian.
- f) Juni 1 kejadian.
- g) Juli 1 kejadian.
- h) Agustus 1 kejadian.
- i) September 1 kejadian.
- j) Oktober 0 kejadian.
- k) November 0 kejadian.
- l) Desember 0 kejadian.

Grafik 2. Angka Kejadian Barang Berpotensi Hilang Tahun 2025



Keterangan :

Angka kejadian barang berpotensi hilang terbanyak di bulan Maret sejumlah 14 kejadian.

Analisis :

- a) Januari 4 kejadian.
- b) Februari 5 kejadian.
- c) Maret 14 kejadian.
- d) April 9 kejadian.
- e) Mei 7 kejadian.
- f) Juni 12 kejadian.
- g) Juli 7 kejadian.
- h) Agustus 7 kejadian.
- i) September 5 kejadian.
- j) Oktober 7 kejadian.
- k) November 5 kejadian.
- l) Desember 9 kejadian.

Grafik 3. Angka Kejadian Kekerasan di Rumah Sakit Tahun 2025



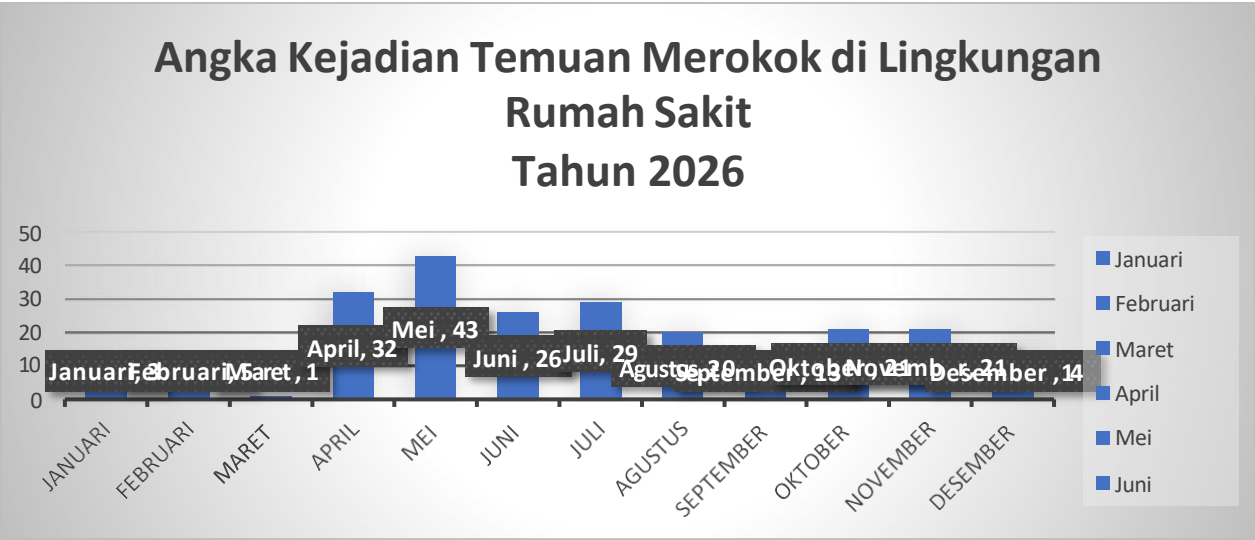
Keterangan :

Tidak ada kejadian kekerasan di lingkungan Rumah Sakit tahun 2025.

Analisis :

- a) Januari 0 kejadian.
- b) Februari 0 kejadian.
- c) Maret 0 kejadian.
- d) April 0 kejadian.
- e) Mei 0 kejadian.
- f) Juni 0 kejadian.
- g) Juli 0 kejadian.
- h) Agustus 0 kejadian.
- i) September 0 kejadian.
- j) Oktober 0 kejadian.
- k) November 0 kejadian.
- l) Desember 0 kejadian.

Grafik 4. Angka Kejadian Temuan Merokok di Lingkungan Rumah Sakit Tahun 2025



Keterangan :

Angka kejadian temuan merokok di area Rumah Sakit terbanyak di bulan Mei sejumlah 43 kejdian.

Analisis :

- m) Januari 3 kejadian.
- n) Februari 5 kejadian.
- o) Maret 1 kejadian.
- p) April 32 kejadian.
- q) Mei 43 kejadian.
- r) Juni 26 kejadian.
- s) Juli 29 kejadian.
- t) Agustus 13 kejadian.
- u) September 13 kejadian.
- v) Oktober 21 kejadian.
- w) November 21 kejadian.
- x) Desember 14 kejadian.

Malang, 31 Desember 2025

Mengetahui

Ketua P2K3RS
RS Prima Husada Malang



Faisal Aminuddin Ilham, S.KM

PLT Direktur
RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestiantini, M.Kes



SURAT KETERANGAN

NOMOR : 016.1/E-SKT/DIR/I/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Resti Lestiantini, M.Kes
Jabatan : PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada

Dengan ini menyatakan bahwa :

Sehubungan dengan kegiatan pengelolaan dan pemantauan alat medis di Rumah Sakit Prima Husada Malang bersama ini kami sampaikan bahwa :

Berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, serta pencatatan yang dilakukan oleh unit terkait, **tidak terdapat kejadian recall (penarikan kembali) alat medis di lingkungan Rumah Sakit Prima Husada Malang selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.**

Hal ini menunjukkan bahwa alat medis yang digunakan telah memenuhi standar mutu, keamanan, dan kelayakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta proses pengelolaan alat medis telah dilaksanakan dengan baik.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 02 Januari 2026

Hormat kami,

PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestiantini, M.Kes



SURAT KETERANGAN

NOMOR : 004.3/I-KEP/DIR/I/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Resti Lestiantini, M.Kes
Jabatan : PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada

Dengan ini menyatakan bahwa :

Sepanjang periode **1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025**, tidak terdapat kejadian **IKP (Insiden Keselamatan Pasien)** yang berkaitan dengan peralatan medis di lingkungan Rumah Sakit Prima Husada Malang

Pernyataan ini dibuat berdasarkan hasil pemantauan, pencatatan, serta pelaporan yang dilakukan secara berkala oleh unit terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 02 Januari 2026

Hormat kami,

PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestiantini, M.Kes